

医疗保障模式

一、医疗保障模式概述

1. 医疗保障模式的含义

- 一个国家/地区为了让居民在生病时能得到必要的医疗服务，而设计出来的**筹资、管理和服务提供**的一整套制度安排。
- 重点看三件事：**钱从哪儿来（筹资）、谁来管（管理体制）、怎么用到看病上（服务提供方式）**。

2. 主要类型（课件列出的四大类）

i. 国家医疗保障（国家医疗保险）模式

- 例：英国、加拿大、澳大利亚、北欧多国，以及我国50～90年代的公费医疗。

ii. 社会医疗保险模式

- 例：德国、日本、韩国、西欧多国，我国现行的城镇职工基本医保、城镇居民医保也属这一类。

iii. 私人（商业）医疗保险模式

- 以美国为代表。

iv. 储蓄医疗保险模式

- 以新加坡为典型，还有马来西亚、印度、印尼等；我国职工个人账户的设计借鉴了它；美国近年有健康储蓄账户（HSA）。
- 实际运行中，很多国家会**混合使用**几种模式，以弥补单一模式的不足。

二、国家医疗保险模式（National Health Service, NHS）

1. 基本概念

- 又叫**国家卫生服务制度**（National Health Service, **NHS**）或**政府医疗保险模式**。
- 核心特征：**政府来办 + 税收来筹资 + 预算来拨款 + 公立（或签约）机构来提供服务 + 居民享免费或低收费**。
- 因服务对个人几乎免费或收费很低，也叫**免费医疗保险模式**。

2. 筹资方式

- 医疗保险基金的**主要来源是税收**，筹资主体是政府。
- 通过**财政预算**把钱拨给卫生部门或医疗机构。

3. 服务提供与管理

- 医疗服务往往具有**国家垄断/高度主导**性。
- 政府自己办的大量医疗机构直接向居民提供医疗服务，或者政府跟民办/私人医生**签合同购买服务**。
- 政府对医疗资源配置和基金使用实行**计划管理和直接调控**。

4. 覆盖范围

- 目标是**全体公民全民覆盖**，人人都有资格享受保险范围内服务。

5. 收费特点

- 居民**免费或低收费**，经济可及性强。

6. 典型国家与历史

- 英国、瑞典最典型；加拿大、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、丹麦和大部分北欧国家也属于这一类。
- 我国50年代到90年代末的**公费医疗**也可归入这一类。

7. 归纳性特点

- 筹资：税收
- 主体：政府
- 覆盖：全民
- 价格：免费/低收费
- 管理：计划+行政主导

三、社会医疗保险模式（Social Health Insurance）

1. 基本概念

- 是指**通过国家立法**，按**强制性社会保险**的原则和方法来筹集、运用医疗保险资金，保证人们**公平获得适宜的医疗卫生服务**的一种制度。
- 具有社会性、强制性、互助性。

2. 历史与代表

- 世界上第一个立法建立医疗保险制度的国家是**德国**，是这一模式的典型。
- 我国的**城镇职工基本医疗保险**和**城镇居民基本医疗保险**也属此类。
- 还有西欧各国、日本、韩国、泰国等。

3. 三大特征

i. 强制性

- 由国家立法，要求特定人群必须参加，防止“只在生病时才参保”的逆向选择。

ii. 依据社区风险费率筹资

- 多以单位加个人缴费，按一定费率统一征收，不以个人健康风险定价，而是按群体来算。

iii. 社会互助共济

- 通过社会统筹把风险在整个参保群体中分担，实现病者得治、众人出钱。

4. 资金运转方式

- 多数国家建立了**社会保险机构**，这些机构通常**脱离市场化的商业保险公司**，比较公益化、非营利化。
- 通过对**全部或大多数人群强制征收医保费**来支付医疗费用。

5. 费用负担

- 一般会有**一定比例自付**（课件后面比较部分说的是20%~30%），以控制费用、避免过度利用。

四、商业医疗保险模式（Private / Commercial Health Insurance）

1. 基本概念

- 由商业保险组织（公司）按照**保险合同**，以人的健康/身体为保障对象，向投保人收取保险费，建立保险基金，对合同约定范围内的医疗费用损失**承担给付责任**的一种合同行为。
- 是**市场化运行**的医疗保险。

2. 作用（课件列了三点）

- 对已受基本医疗保险保障的人作有益补充**
 - 比如医保报不了的高端药、特殊病房、更多次住院等，可由商业保险补。
- 覆盖尚未被基本医疗保险覆盖的人群**
 - 一些国家基本医保有盲区，商业保险可填补。
- 在基本医疗保险领域发挥积极作用**
 - 可以推动服务多样化、推动医疗市场竞争。

3. 理论基础

- 强调医疗服务是一种**商品**，应当由**市场来提供和调节**。
- 与之相配的理念是**健康自我责任论**——个体应对自己健康与医疗消费承担更大责任。
- 以美国为代表，覆盖率相对最低。

五、储蓄医疗保险模式（Medical Savings Scheme）

1. 基本概念

- 依据法律规定，以**家庭为单位**、**强制性地储蓄医疗基金**，让家庭在时间维度上**纵向逐步积累**，以解决将来患病就医的资金问题。
- 典型国家：**新加坡**；还有马来西亚、印度、印尼等。

- 我国职工医保里的**个人账户**就是参考新加坡的制度建立的。
- 美国近年流行的**健康储蓄账户**（Health Savings Account, **HSA**）也属于类似思路。

2. 基本特点（课件四条）

- i. **筹资方式——法律强制“储蓄”**：不是缴给统筹基金，而是强制你把一部分钱存入专门账户。
- ii. **筹资责任——以个人责任为基础**：谁将来要看病，谁先把钱存起来。
- iii. **基金积累——纵向积累资金**：随着时间推移账户里的钱越来越多，供以后使用。
- iv. **补充保险——自愿参加**：账户之外需要的再买补充险。

3. 优点

- **保障对象覆盖广**：强制每个家庭存，所以人人有账户。
- **筹资机制有创新**：不完全靠税，也不完全靠统筹，个人可见度高。
- **基金利用效率高**：钱基本是自己的，减少浪费。
- **可缓解代际矛盾**：不是年轻人当期大量补贴老年人，而是自己为自己将来存钱。
- **选择自由有保证**：账户里的钱使用上自由度更大。

4. 缺点

- **横向公平性较低**：大家收入不同、存钱能力不同，看病保障水平也不同。
- **互助共济不足**：大病、突发重病的人一旦账户不够，还是要靠别的制度。
- **以个人选择为前提，科学使用困难**：普通人并不总能准确预测和规划自己的健康支出。

六、四种模式的比较要点

课件后面有一个“医疗保障模式比较”，主要从**覆盖率**、**个人自付比例**、**卫生服务可及性**三个角度说的，我们逐项记：

1. 覆盖率

- **国家医疗保障模式**：全民覆盖。
- **社会医疗保险**：覆盖率较广，日本100%，法国99%，德国88%。
- **以商业保险为主的美国**：最低，约85%。
- → 记忆点：公共性越强，覆盖率越高。

2. 个人自付比例

- **国家医疗保障模式**：基本免费。
- **社会保险模式**：通常个人自付20%~30%。
- **美国商业模式**：有起付线、共付额等多层次自付设计，如住院60天以内1156美元以内要自付，门诊是155美元/年 + 费用的20%。
- → 记忆点：越市场化，费用分担越复杂，个人负担越高。

3. 卫生服务的可及性与就医自由度

- **日本、法国**：就医行为自由。

- **英国**：有**全科医师守门人制度**，患者必须先看家庭医生，再转诊，行为受限。
- **美国**：
 - PPO（Preferred Provider Organization）自选式保险计划：患者可自由选医生，但收费高。
 - HMO（Health Maintenance Organization）健康维持组织：必须在指定医生处就医，费用低（约PPO的1/2~1/3）。
- → 记忆点：为了控费，就医自由往往会被限制；自由度越高，通常费用就越高。

4. 模式特点一句话版

- **国家模式**：税收→政府→公立/签约机构→免费/低费
- **社会保险模式**：强制参保→社会保险机构→社会统筹+个人自付
- **商业模式**：市场买保险→按合同理赔→强调个人责任
- **储蓄模式**：强制存钱→个人/家庭账户→缺互助，要补充险

5. 混合模式

- 课件提到：实际中以上三种（国家、社会保险、商业）**综合应用**是最常见的。国家负责基本，社会保险负责主体覆盖，商业保险做补充。

七、中国医疗保障体系的改革与发展

1. 现有格局：“3+1”体系

- “3”指三大基本制度：
 - a. 城镇职工基本医疗保险
 - b. 城镇居民基本医疗保险
 - c. 新型农村合作医疗
- “+1”指：**城乡医疗救助制度**
- 这四块构成了我国目前的基本医疗保障体系。

2. 存在的突出问题（课件原话要点）

- 基本医疗保险制度**尚未惠及所有人群**，仍有未覆盖人群。
- **城乡制度分设**：城镇一套、农村一套，制度不统一。
- **资源分散、管理分离**：多头管理，统筹层次低。
- **待遇不均衡、城乡不衔接、流动不适应**：农民进城、跨区域就业的人群接续困难。
- 导致：制度体系**差异性大、碎片化**，保障水平总体偏低，待遇不公平。
- 这些都是今后制度建设要优先解决的。

3. 课件列的“全民医疗保险制度的发展趋势”（三步走）

- **第一步（2008–2012）**：建设覆盖全民的多元化医疗保障体系。
- **第二步（2013–2020）**：建立**区域性统一的国民医疗保险制度**——向统筹层次更高、制度更统一迈进。

- **第三步（2021–2050）：**建立公平、普惠的全民健康保险制度，目标是全面、均等、持续的保障。
- 可以看出路线是：先全覆盖 → 再统一 → 再提公平和普惠。

八、重点英文单词与对应概念

下面列的是课件里直接出现或能从课件内容推导出来、在写报告/查资料时最常用的英文表达，你可以直接贴用。

1. 医疗保障模式 — **Medical Security Model / Medical Care Security Model**
2. 国家医疗保险模式 — **National Health Service (NHS) / Government Medical Insurance Model**
3. 国家卫生服务制度 — **National Health Service, NHS**
4. 社会医疗保险 — **Social Health Insurance (SHI)**
5. 商业医疗保险 — **Commercial Health Insurance / Private Health Insurance**
6. 储蓄医疗保险 — **Medical Savings Scheme / Savings-based Medical Insurance**
7. 健康储蓄账户 — **Health Savings Account (HSA)**
8. 免费医疗保险模式 — **Free Medical Insurance Model**
9. 筹资 — **Financing**
10. 财政预算拨款 — **Budgetary Appropriation / Fiscal Budget Allocation**
11. 覆盖范围 — **Coverage / Population Coverage**
12. 全民医疗保险制度 — **Universal Health Insurance System**
13. 医疗服务可及性 — **Accessibility of Health Services**
14. 全科医师制度 / 守门人制度 — **General Practitioner (GP) System / Gatekeeper System**
15. 优先提供组织 — **Preferred Provider Organization (PPO)**
16. 健康维持组织 — **Health Maintenance Organization (HMO)**
17. 社会互助共济 — **Mutual Aid and Risk Sharing**
18. 起付线 — **Deductible**
19. 个人自付比例 — **Co-payment / Co-insurance**
20. 医疗救助 — **Medical Assistance**
21. 碎片化 — **Fragmentation**
22. 普惠的全民健康保险 — **Equitable and Universal Health Insurance**

医疗保障概述

第一节 医疗保障相关概念

一、风险与保险

1. 风险的内涵

- **风险的本质**：是一种客观存在的状态，它说的是“会不会发生损失”和“损失有多大”都不确定。
- **两个不确定性**：
 - i. **事件发生与否的不确定性**：可能发生也可能不发生。
 - ii. **损失大小的不确定性**：真发生了，损失可能大也可能小。
- **衡量风险的两个维度**：
 - **损失概率**：一定时期内、在一定范围内，发生损失的次数 ÷ 总的风险单位数，用来表示“会不会出事”的可能。
 - **损失率/损失程度**：一次事故造成的损失占标的总价值的比例，用来表示“出事了有多严重”。

2. 风险的特征

- **客观性**：不以人的意志为转移。
- **损害性**：一旦发生就会带来不利后果。
- **不确定性**：发生时间、次数、损失大小都说不准。
- **可测定性**：虽然不确定，但可以用统计方法估计。
- **发展性**：随着社会、技术、环境变化，风险会变化。

3. 保险

- **保险的内涵**：是一种“共同分担经济损失的补偿活动”，本质是参加的人之间建立**互助共济的分配关系**，用经济手段把个体的不确定损失摊到集体上。
- **属性**：属于经济范畴，是一种**经济补偿制度**。
- **不是所有风险都能保**：只有满足条件的“可保风险”才能通过保险方式转移。

4. 可保风险需满足的条件

1. **纯粹风险**（不是投机赚钱那种，只是可能发生损失）。
2. **偶然性**（不是必然发生的，也不是人为必然安排的）。

3. **存在大量同质风险**（要有一群结构类似的风险，保险公司才能用大数法则摊）。
4. **损失必须是意外的**。
5. **有发生重大损失的可能性**（有保的必要）。

二、社会保障

1. 定义

- 社会保障制度是一个很大的**社会政策 + 法律体系**。
- 不同国家项目不一样、叫法也不一样。
- 中国习惯分成四块：**社会救助、社会保险、社会福利、特殊保障**。

2. 我国社会保障的主要内容

1. 社会救助

- 是国家立法保障的公民基本权利之一。
- 解决“最低生活维持不了”的问题，具有**托底作用**。
- 面向贫困人口，不是普遍福利，体现再分配。

2. 社会保险

- 国家立法**强制**征收社会保险费，形成基金。
- 当劳动者因**老、病、伤、残、生育、死亡、失业**等导致收入中断或减少时，社保给付保障基本生活。
- 影响面最广、对社会经济作用最大，是社会保障**核心部分**。

3. 社会福利

- 广义：一切改善人民物质精神生活的社会措施。
- “中义”在西欧常跟社会保障差不多。
- 我国多用**狭义社会福利**：作为社会保障的一部分，包括社会津贴、社会福利服务、职业福利。

4. 特殊保障（社会优抚）

- 面向军属、烈属、残疾军人、退伍军人等特殊群体。
- 给特殊人群设立“标准或给付条件不同”的保障。
- 有独立管理机构，确保物力、财力和安置落实。

三、医疗保障

1. 定义

- 是现代政府职能的重要组成部分。
- 通过动员全社会的医疗卫生资源，筹集和支付医疗保障基金，组织医疗服务和必要的医疗物资（药品、疫苗、器械等），来**分担社会成员的疾病风险、保障人群健康**的一项社会保障制度安排。

2. 五层含义

1. **政府是主体**：组织和实施医疗保障是政府责任。
2. **筹资多元化**：政府、企业、个人都有责任。
3. **保障对象是全体社会成员**：制度是组合式、多形式、多层次的。
4. **功能是弥补疾病风险导致的损失**：可以保直接医疗费，也可以保间接费用（收入减少、交通费等）。
5. **医疗保障的内涵 > 医疗保险**：医疗保险只是医疗保障体系中的重要组成部分。

四、医疗保险

1. 内涵

- 按照强制的政策法规或自愿契约，把多渠道筹来的钱集中成基金，对参保人因病发生的医疗费用进行经济补偿。
- 它是**分散疾病风险**、弥补直接医疗费用的制度。

2. 类别

- **社会医疗保险**：强制性，由政府主办，法律政策组织实施。
- **商业医疗保险**：自愿购买，由商业保险公司经营，通过合同约定给付。

3. 社会医疗保险 vs 商业医疗保险

- **目的**：商业追求利润最大化；社会医保追求社会效益、基本保障。
- **性质**：商业遵循平等自愿；社会医保具有强制性，符合法定条件必须参加。
- **保障范围**：商业由双方协商；社会医保由国家统一规定。
- **权利义务对等**：商业是“多投多保”；社会医保强调应保尽保、并不完全等价。
- **覆盖对象**：商业对象灵活、社会化低；社会医保对象法律规定、社会化高。

五、医疗保障与社会保障、医疗保险的关系

1. 医疗保障与社会保障

- 社会保障是大盘，含养老、失业、工伤、疾病、健康等9大类。
- 医疗保障是其中抵御疾病与健康风险的重要组成部分。
- 医疗保障里的社会医疗保险与养老、失业、工伤一起构成社会保险；医疗保障里的医疗救助也属于社会救助。

2. 医疗保障与医疗保险

- 医疗保障是**多层次、多形式、安全网**，不应是单一制度。
- 医疗保险（社会+商业）都是医疗保障不可缺少的组成部分。
- 在我国：社会医疗保险是**主体层**，商业医疗保险是**补充层**，补覆盖没被社保覆盖的人群、项目和药品。

第二节 医疗保障的原则与构成

一、医疗保障的原则

1. 政府主导责任原则

- 医疗保障首先是政府责任，要立法、设计、规划、组织、实施，还要财政支持。
- 尤其是对弱势人群的医疗救助，政府几乎承担全部责任。
- 但强调政府不等于排斥个人责任，二者要平衡。

2. 公民权原则

- 宪法规定：公民在年老、疾病或丧失劳动能力时有从国家和社会获得物质帮助的权利。
- 特点：
 - **法定性和不容侵犯性**：这是法定的权利。
 - **平等/公平性**：不分民族、性别、地位等，都应享有同等权利并履行同等义务。
 - **普遍性**：要覆盖所有公民。

3. 多层次与多种形式相结合原则

- 因为目标多、个人需求差异大，所以制度要多层次：国家卫生服务制度、社会医保是核心；医疗救助兜底；商业保险等作补充。各国一般都是多种形式并存。

4. 筹资责任分担原则

- 没有哪个国家能只靠一个主体出钱。
- 一般由国家、雇主、个人共同分担，慈善也可参与。
- 具体形式不同：社保多由雇主+雇员；国家卫生服务制度多由政府税收；救助主要政府出；补充保险多是个人或企业+个人。

5. 公平与效率相结合原则

- **公平：**
 - 筹资公平：按支付能力出钱，弱者可减免。
 - 获得公平：机会均等+待遇标准均等（同病同保障）。
- **效率：**
 - 微观效率：筹钱成本低、用钱少浪费、服务合理。
 - 宏观效率：一定投入下让覆盖最多、补偿高、服务范围大、健康产出最大。

6. 与经济发展水平相适应原则

- 医保发展不能脱离经济基础，要渐进、分阶段。
- 超水平会不可持续，低水平又发挥不了保障功能。

二、医疗保障制度的构成

（一）国家医疗保障

1. 基本医疗保障制度（主体、核心）

- 主要两种形式：
 - **社会医疗保险 (social medical insurance)**：政府立法推行，强制特定群体缴费，用基金给付医疗。
 - **国家卫生服务制度 (national health system)**：政府办医疗机构，用一般税收拨款，向全民提供免费或低收费服务。

2. 医疗救助 (medical financial assistance)

- 面向社会弱势群体，提供医疗援助，是最后一道托底防线。
- 即使基本制度已建立，因贫困、重病等仍会有人承受不起，所以救助会长期存在。

（二）补充性医疗保障

1. 企业补充医疗保险

- 企业在参加社会医保基础上，结合自身效益，为职工再加一层保障。
- 资金来源可企业承担，也可企业+个人。
- 政府可通过税收优惠鼓励企业做这件事。
- 多数情况下是企业给职工买商业保险。

2. 商业医疗保险

- 自愿签约、缴费，保险公司按合同给付或代付医疗服务。

3. 家庭保障

- 不是社会性措施，但在很多发展中国家很重要。
- 通过家庭内部互助来承担疾病风险。
- 完善的医疗保障体系不应过度依赖家庭，否则会加重家庭负担、加剧社会不公平。

第三节 医疗保障制度历史发展演进

一、萌芽时期

- 主要来源：**中世纪欧洲的救济传统**。
- 三股重要力量：
 - i. **教会慈善救济**：办救济院、医院、疯人院，用收入的一部分做慈善。
 - ii. **个人慈善救济**：有钱人特别是商人捐财建慈善机构。
 - iii. **行会组织的救济**：会员交会费，行会集中资金帮生病或困难会员。
- 这一时期还没有专门独立的医疗救助制度，但在综合性社会救助里已经有医疗内容，可视为现代医疗保障的萌芽。

二、建立时期（1883—二战结束）

- 1883年德国颁布《疾病社会保险法》被视为现代社会医疗保险的起点，要求建立疾病保险基金。
- 这个制度的背景是德国要用国家干预来调节劳资矛盾。
- 随后很多国家跟进：法国1928《社会保险法》、意大利1898/1910的保险、瑞典1910《疾病保险》、英国1911《国民保险法》，日本1924、巴西1923、智利1924、新西兰1938等，都陆续建立以医疗保险为内容的社会保障。
- 两个推动因素：
 - i. **1929—1933世界经济危机** → 各国要用社会保障来刺激需求。
 - ii. **凯恩斯主义兴起** → 提倡国家用社会保障稳定经济。
- 这一时期的特点：
 - 国家开始建立专门的医疗保障制度；
 - 但覆盖面有限，多数只管城市产业工人及家属；
 - 保障内容多是补偿因病的直接损失；
 - 制度多是分散的、不成体系的。

三、繁荣发展时期（二战后—20世纪70年代）

- 标志性事件：**英国1948年宣布建成世界上第一个福利国家**，建立起“从摇篮到坟墓”的全面保障，包括国民保险、国民卫生服务、社会救济等。
- 此后瑞典、法国、德国、日本、土耳其、埃及、中国等都不同程度扩大了医疗保障的覆盖和制度。中国方面：1952年开始实施公费医疗，1951《劳动保险条例》及其后续细则，逐步建立起职工劳保医疗制度。
- 这一时期的总体特点：
 - i. 建立医疗保障制度的国家数量大幅增加；

- ii. 覆盖面不断扩大，有的做到全民；
- iii. 制度形态从单一走向多元；
- iv. 水平不断提高、支出占GDP比重显著上升。

四、改革时期（20世纪70年代末以来）

- **背景：**
 - 两次石油危机→发达国家出现“滞胀”；
 - 医疗科技进步+人口老龄化→医疗服务需求猛增、费用快速上涨；
 - 福利制度显得太昂贵，成了财政负担。
- **改革做法：**核心就是“开源节流”
 - 开源：征社会保障所得税、提高投保费率、增加保险收入，对部分福利开始收费；
 - 节流：降低给付水平或减少给付可得性。

第四节 医疗保障学研究

一、医疗保障学的定义

- 是一门运用多学科理论和综合研究方法来分析医疗保障问题、揭示其发展与运行规律的新兴交叉学科。
- 把医疗保障当成独立学科，有利于打破原来分散研究的状况，使理论系统化。

二、研究内容

1. **医疗保障的基础理论**
 - 包括医疗保障的基本概念、范畴
 - 以及公共经济学、福利经济学、卫生经济学、福利社会学等相关知识
 - 内容有：内涵、性质、特点、原则、作用、发展史、体系等。
2. **医疗保障的基本原理**
 - 针对实践的通用性原则
 - 如基金筹集与配置、基金测算、费用支付与控制、基金运行与管理、医疗服务提供与监管、医疗保障评价等。
3. **医疗保障制度理论**
 - 研究各种实现形式及运行规律
 - 类型包括：国家卫生服务制度、社会医疗保险、商业医疗保险、储蓄医疗保险、医疗救助与社会慈善、补充医疗保险等。
4. **医疗保障的政策、法律与法规**

- 研究立法、政策制定和实施
- 探讨如何用国家和法律的力量来规范和维持制度的正常运行，推动法治化管理。

三、研究方法

1. 比较研究法

- 横向比较：不同时空的不同国家/地区医疗保障进行对比，看共性和个性。
- 纵向比较：同一国家不同时期的医疗保障进行比较，看发展变化和规律。

2. 调查研究法

- 医疗保障问题很现实，要面向实践
- 用问卷、访谈收集第一手资料
- 综合运用流行病学、人口学、卫生服务、社会学、市场调查等多学科方法
- 调查类型有普查、重点、典型、个案、抽样，其中典型和抽样用得更多。

3. 实验研究法（试点研究）

- 控制变量、观察因果
- 在社会科学中多表现为“制度试点”
- 中国医保改革中大量采用：如90年代镇江、九江的职工医保试点；2003新农合试点；2007城乡居民保试点；城乡大病保险试点；城乡医疗救助试点等，用来验证可行性、探索新模式。

重点英文单词（按课件内容汇总）

- risk 风险
- loss probability 损失概率
- loss ratio / loss severity 损失率/损失程度
- insurance 保险
- insurable risk 可保风险
- social security 社会保障
- social assistance 社会救助
- social insurance 社会保险
- social welfare 社会福利
- special protection / special social benefits 特殊保障/社会优抚
- medical security / health security 医疗保障
- medical insurance 医疗保险
- social medical insurance 社会医疗保险
- commercial medical insurance 商业医疗保险
- National Health System (NHS) 国家卫生服务制度

- medical financial assistance 医疗救助
- principle of government responsibility 政府主导责任原则
- citizenship right 公民权
- multi-level and multi-form 多层次与多种形式
- financing responsibility sharing 筹资责任分担
- equity and efficiency 公平与效率
- basic medical security system 基本医疗保障制度
- supplementary medical security 补充性医疗保障
- enterprise supplementary medical insurance 企业补充医疗保险
- historical evolution of medical security 医疗保障的历史演进
- comparative study 比较研究法
- survey / field survey 调查研究法
- experimental / pilot study 实验研究法、试点研究

第三章 医疗保险的需求和供给

一、学习目标

1. 掌握：医疗保险**需求与供给**的基本含义及其影响因素。
2. 会看：医疗保险**需求曲线、供给曲线**及其变动方式。
3. 理解：**需求弹性、供给弹性**在医疗保险中的含义和类型。
4. 掌握：医疗保险**市场均衡**的形成与变动。
5. 理解：医疗保险**市场失灵**的原因与表现，以及**政府在医疗保险市场中的职能**。

【英文关键词】

- medical insurance
- demand
- supply
- elasticity
- market equilibrium
- market failure
- government intervention

第一节 医疗保险需求

1. 医疗保险需求的内涵

(1) 概念

医疗保险需求（**medical insurance demand**）是指：在一定时期内、一定价格水平上，消费者**愿意并且能够购买**的医疗保险数量。这里强调两个条件：

- “愿意”=主观上想买
 - “能够”=有支付能力
- 需求的表现包括两个层面：
- **物质方面**：发生医疗费用后能得到经济补偿
 - **心理方面**：获得安全感、减轻不确定性带来的焦虑

(2) 经济学解释

1. 风险与不确定性引出医疗保险需求

- **自我保险 (self-insurance)**: 自己留钱、储蓄、家庭互助来分散风险
- **购买医疗保险 (purchasing medical insurance)**: 把不确定的大额医疗支出, 换成确定的小额保费

2. 医疗服务市场的信息不对称 (information asymmetry) 会提高人们对保险的需求

- 患者不了解将来会得什么病、花多少钱
- 医生和医疗机构掌握更多信息
- 这种不对称使个体更愿意用保险来转移风险

3. 总效用、预期效用与财富的关系

- 财富越高, 效用增加但**边际效用递减**
- 在不确定损失下, 购买保险可以让“预期效用”上升, 因此有保险需求
- 用预期效用曲线可以说明: 风险厌恶者愿意支付高于预期损失的一笔“附加费”(loading) 来买保险

2. 医疗保险需求的影响因素

影响需求的不是单一价格, 课件给了一个比较全的列表:

1. 疾病风险 (disease risk)

- 疾病发生概率越高 → 愿意支付的保费附加费越高
- 预期损失越大 → 保险需求越大
- 课件图示: 不同疾病发生概率、不同预期损失下, 消费者愿意支付的附加费不同

2. 医疗保险价格 (price/premium)

- 保费越高, 一般需求越少 (价格与需求量反向)

3. 医疗保险的经济补偿能力 (compensation capacity / coverage level)

- 报销比例高、覆盖范围广、自付比例低 → 保险的吸引力更强 → 需求增加

4. 消费者收入 (income)

- 医疗保险多为“正常品”, 收入越高, 越有能力和意愿购买

5. 消费者的避险心态 (risk aversion / risk attitude)

- 风险厌恶程度高的人 → 更愿意为确定性付费 → 需求大

6. 相关医疗保险产品的价格 (price of related products)

- 有替代/互补关系的保险产品的价格变化, 会影响本保险的需求 (为后面交叉价格弹性铺垫)

7. 医疗服务的供给 (medical service supply)

- 医疗服务容易获得、质量好, 则买保险能“用得上”, 保险需求可能上升

8. 其他因素

- 政策、社会保障状况、地区医疗水平、家庭结构等

3. 医疗保险需求曲线及其变动

(1) 需求曲线的含义

- 医疗保险需求函数：用来表示医疗保险需求量与各种影响因素之间的关系，一般写成
 - $Q_d = f(P, I, risk, coverage, \dots)$
 - 其中 P 是保险价格， Q_d 是需求量
- 需求表：列出在不同价格水平下愿意购买的数量
- 需求曲线：通常向右下方倾斜，表示价格越高，需求量越少

(2) 需求曲线的“量的变动”与“曲线的变动”

1. 需求量的变动 (change in quantity demanded)

- 原因：价格本身改变
- 表现：在同一条曲线上点的移动

2. 需求的变动 (change in demand)

- 原因：除价格以外的因素变化（如收入、疾病风险、报销比例等）
- 表现：整条曲线向右或向左移动

4. 医疗保险需求弹性

(1) 概念

- 一般形式：

$$E = \frac{\Delta Y / Y}{\Delta X / X}$$

表示需求量对某个影响因素变动的敏感程度

(2) 分类

1. 价格弹性 (price elasticity of demand)

- 假设 $Q = f(P)$ ，则

$$E_d = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P}$$

- 五种类型：
 - 富有弹性 $|E_d| > 1$
 - 缺乏弹性 $|E_d| < 1$
 - 单位弹性 $|E_d| = 1$

- 完全弹性
- 完全无弹性

- 医疗保险很多时候价格弹性不会像普通消费品那么大，但要看替代性、收入水平等

2. 收入弹性 (income elasticity of demand)

- 假设 ($Q = f(I)$)，公式同上
- 可分为：正向（正常品）、大于1（奢侈性保险）、小于1（必需性保险）

3. 交叉价格弹性 (cross-price elasticity)

- 假设 X 保险的需求量 ($Q_X = f(P_Y)$)，则
[
 $E_{XY} = \frac{\Delta Q_X / Q_X}{\Delta P_Y / P_Y}$
]
• 三种类型：
 - 替代品： $E > 0$
 - 互补品： $E < 0$
 - 无关： $E \approx 0$

【本节英文关键词】

- medical insurance demand
- self-insurance
- risk aversion
- information asymmetry
- demand curve
- change in quantity demanded
- change in demand
- price elasticity of demand
- income elasticity
- cross-price elasticity
- loading / premium
- coverage

第二节 医疗保险供给

1. 医疗保险供给概述

(1) 概念

医疗保险供给 (**medical insurance supply**)：医疗保险机构在一定时期内、一定的医疗保险价格（保

费)条件下, **愿意并且能够**提供的医疗保险产品数量。

形成供给的两个前提:

1. 有提供服务的**意愿**
2. 有提供服务的**能力**

(2) 供给的特点

1. **复杂性 (complexity)**: 保险产品设计、精算、合同条款、与医疗服务的衔接都很复杂
2. **专业性 (professionalism)**: 需要精算、医学、法律等专业支持
3. **垄断性/集中性 (monopolistic feature)**: 有的国家由政府或少数大型机构经办
4. **外部性 (externality)**: 医疗保险的存在能改善整个社会的健康保障水平, 具有正外部性

(3) 供给者的组织形式

1. **政府部门经办或非营利性机构供给**: 如社会医保
2. **经营性保险公司供给**:
 - 人寿或财产保险公司中的医疗险
 - 专业医疗保险公司
 - 合作式医疗保险组织 (mutual / cooperative)

(4) 医疗保险供给者的经济行为

1. **抑制道德风险 (moral hazard control)**
 - 对医疗服务需方: 通过**费用分担方式 (cost-sharing) **来抑制过度就医
 - 对医疗服务供方: 通过**支付方式创新 (payment reform) **抑制诱导需求
2. **管控逆向选择 (adverse selection control)**
 - 风险选择 (risk selection)
 - 限制承保内容
 - 合同期限设计
 - 定期调整保费
3. **金融行为**: 资金运用、准备金管理等

2. 医疗保险供给的影响因素

1. **医疗保险价格 (premium / price)**: 价格高 → 利润空间大 → 供给量增加
2. **医疗保险成本 (cost)**: 成本上升会压缩供给
3. **医疗保险机构的承保能力 (underwriting capacity)**: 资金、管理、风控能力越强 → 能供给的保单越多
4. **医疗保险机构的信誉度 (reputation / credibility)**: 信誉高更容易吸引参保, 实际会反过来扩大供给

5. **医疗服务供给 (medical service supply)**: 医疗资源充足、有能力结算, 保险机构更容易设计产品并供给
6. **政府行为因素 (government intervention / regulation)**: 税收优惠、补贴、监管政策都会影响供给

3. 医疗保险供给曲线及其变动

(1) 供给曲线

- 一般是向右上方倾斜: 价格越高, 供给越多

(2) 供给量的变动

- 由价格变动引起 → 在同一条供给曲线上移动

(3) 供给的变动

- 由成本、技术、政策等非价格因素引起 → 整条供给曲线移动

(4) 供给弹性 (supply elasticity)

课件列了“五种类型”:

- 富有弹性
- 缺乏弹性
- 单位弹性
- 完全弹性
- 完全无弹性

并提到两个特征:

1. 商业医疗保险可替代性强 (可以设计多种产品)
2. 商业医疗保险所需货币投入量更大 (影响短期供给弹性)

【本节英文关键词】

- medical insurance supply
- underwriting capacity
- moral hazard
- adverse selection
- cost-sharing
- payment reform
- supply curve

- change in supply
- change in quantity supplied
- supply elasticity
- regulation

第三节 医疗保险需求与供给的均衡

1. 均衡的形成

- 在医疗保险市场中，**需求曲线**与**供给曲线**相交的点 → 决定了**均衡价格 (equilibrium price)**和**均衡数量 (equilibrium quantity)**
- 这个点表示：消费者想买的数量 = 机构想卖的数量

2. 均衡的变动

1. 需求变动对均衡的影响

- 需求增加 → 均衡价格↑ 均衡数量↑
- 需求减少 → 均衡价格↓ 均衡数量↓

2. 供给变动对均衡的影响

- 供给增加 → 均衡价格↓ 均衡数量↑
- 供给减少 → 均衡价格↑ 均衡数量↓

3. 需求和供给同时变动

- 同向变动：数量方向确定，价格不一定
- 反向变动：价格方向确定，数量不一定

(课件有“供求同时变动的的影响”的图示，就是说明这个)

【本节英文关键词】

- equilibrium
- equilibrium price
- equilibrium quantity
- shift in demand
- shift in supply
- comparative statics

第四节 医疗保险的市场失灵和政府的干预作用

1. 医疗保险市场的概念与特点

(1) 定义

医疗保险市场：发生医疗保险买卖的场所或制度安排，可是有形的、也可以是通过网络/电子化方式达成交易的接洽点。实质上是：**买方和卖方相互作用并决定交易价格和数量的制度。**

(2) 特点

1. 买卖双方是一种**契约交换关系 (contractual relationship)**
2. **多方主体共存 (multiple agents)**：参保人、保险机构、医疗服务提供者、政府等都在里面

2. 医疗保险的市场失灵

(1) 概念

当医疗保险市场因为达不到完全竞争等理想条件，**不能实现资源的有效配置**，还有“帕累托改进”的空间，就叫市场失灵 (market failure)。

(2) 根本原因：信息不对称 (information asymmetry)

- 保险公司不了解参保人真实风险
 - 参保人不了解未来医疗服务的真实价格和必要性
 - 医疗机构掌握更多诊疗信息
- 各方处于信息不对等状态，导致市场不能自动达成最优

(3) 表现形式

1. **逆向选择 (adverse selection)**：高风险的人更愿意参保，低风险的人退出 → 风险池恶化
2. **风险选择 (risk selection)**：保险公司主动挑选低风险客户，排斥高风险人群
3. **道德风险 (moral hazard)**：参保后因为有报销保护而过度消费医疗，或医疗机构过度提供服务

3. 政府在医疗保险市场中的职能

1. 设计和规范医疗保险市场模式

- 制定基本医保框架、补充商业医保政策、准入规则

2. 监督和管理医疗保险市场运行

- 费率审批、合同条款监管、反垄断、反欺诈、信息披露

3. 弥补医疗保险市场不足

- 覆盖市场不愿承保的高风险人群

- 提供财政补贴
- 建立再保险或风险调剂机制

【本节英文关键词】

- medical insurance market
- market failure
- information asymmetry
- adverse selection
- risk selection
- moral hazard
- government intervention
- regulation
- Pareto improvement

汇总：重点英文单词表

中文	英文
医疗保险需求	medical insurance demand
医疗保险供给	medical insurance supply
需求曲线	demand curve
供给曲线	supply curve
需求弹性	demand elasticity
价格弹性	price elasticity
收入弹性	income elasticity
交叉价格弹性	cross-price elasticity
自我保险	self-insurance
风险厌恶	risk aversion
信息不对称	information asymmetry
医疗保险价格/保费	premium / price

中文	英文
经济补偿能力	compensation capacity / coverage
承保能力	underwriting capacity
道德风险	moral hazard
逆向选择	adverse selection
风险选择	risk selection
市场失灵	market failure
均衡价格	equilibrium price
均衡数量	equilibrium quantity
政府干预	government intervention
成本分担	cost-sharing

第五章 医疗保障筹资

一、学习目标

1. 掌握**医疗保障筹资**的基本概念、构成要素及其意义。
2. 理解**医疗保障筹资的原理与原则**，能够说出“与经济发展水平相适应、以法律为依据、保障基本、合理分担、公平互助”等原则的含义。
3. 熟悉**医疗保障筹资的渠道与基金筹集形式**：财政拨款、用人单位/个人缴费（税）、其他渠道；国家税收式、强制缴费式、自由投保式、储蓄账户式的特点与优缺点。
4. 掌握**医疗保障基金的运行流程及财务运行模式**：现收现付制、完全积累制、部分积累制的内涵及比较。
5. 能分析**征收医疗保障税与征收医疗保障费**的优缺点。

二、基本概念与意义

1. 医疗保障基金的概念

- **定义**：医疗保障基金（**funds of medical security**）是根据国家法律、法规和政策规定，为实施**全民医疗保障制度**，以**法定或约定方式**建立起来，由专门机构管理、专门用于医疗保障各项的**专项资金**。
- **我国基金的分项建立**：一般按不同项目分别建账，如：
 - 社会医疗保险基金
 - 医疗救助基金
 - 补充医疗保险基金
 - 商业健康保险基金
 - 医疗慈善基金
 - 医疗互助基金→ 特点：**分项建立、分账核算、统一管理**。
- **关键词（英）**：
 - medical security fund
 - statutory / contractual establishment

- special-purpose fund

2. 医疗保障筹资的概念

- **医疗保障筹资 (medical security financing)**：是“医疗保障基金筹集”的简称。
- **狭义**：指医疗保障项目的**实施主体**将社会资金通过各种渠道**筹集起来的过程**。
- **广义**：不仅包括基金的**筹集**，还包括**分配与使用**等环节，即把钱收上来、再按制度付出去的整个闭环。
- 是一个**行为过程**，包含多个基本要素。

3. 医疗保障筹资的六大要素

1. **筹资主体**：谁来筹——政府、用人单位、个人、社会组织等。
2. **筹资客体**：向谁收、对什么征收——社会资金、个人收入、单位工资总额等。
3. **筹资方式**：征税、征费、自由投保、储蓄账户等。
4. **基金构成**：基本医保基金、补充/商业/救助等不同层级基金。
5. **基金累积方式**：现收现付、完全积累、部分积累。
6. **筹资水平**：收多少的问题，要与经济发展和支付能力相匹配。

- 关键词 (英)：
 - financing subject
 - financing object
 - financing method
 - fund accumulation

4. 医疗保障筹资的意义

- **决定保障水平**：筹资水平直接决定被保障群体能报多少、能保多久。各国实践证明，**足额筹资是制度正常运行的核心环节**。
- **有利于分担费用、控制不合理医疗费用**：多方筹资能增强参保人自我保障意识，同时通过支付制度引导，就能对过度医疗起约束作用。
- **提高卫生资金配置效率**：通过医保的支付方式，能引导患者到基层、促进分级诊疗，推动卫生资源合理配置。
- 关键词 (英)：
 - financing level
 - risk sharing
 - efficiency of health resource allocation

三、医疗保障筹资的相关理论基础

- 医疗保障是社会保障的重要组成部分，本质上是**国民收入再分配机制**的一部分。
- 从“资金筹集 → 资金分配”构成了医疗保障制度运行的**主线**。
- 任何医疗保障项目要落地，**第一步一定是筹资**，然后才能谈待遇支付，所以**筹资既是基础，也是中心环节**。
- 筹资实践中的四个要求：
 - i. 筹集方式要与制度模式相适应；
 - ii. 筹资渠道要畅通；
 - iii. 资金来源要稳定；
 - iv. 已筹资金要能满足当前制度需要。
- 各国通常是**征税型、征费型与自由筹资并存的多元混合模式**，只是比重不同。
- 政府责任最重，财政拨款是重要来源，可体现直接投入、运行费用承担、税收优惠等多种形式。
- 关键词（英）：
 - income redistribution
 - mixed financing mode
 - government-dominated financing

四、医疗保障筹资的特点

1. 立法强制性（legal compulsoriness）

- 我国以政府主导的**社会医疗保险**为主体，依据《中华人民共和国社会保险法》在全社会**强制实施**。
- 基金的筹集、管理和使用都具有法律约束力。
- 商业健康保险、民间医疗互助一般是**合同性或约定性**，不具备国家立法强制性。

2. 专款专用性（earmarked use）

- 基金必须依法依规设立、按项目分账核算、专款专用，**不得挪用**。
- 医疗机构在报销时要遵守诊疗规范，不得分解住院、过度诊疗、重复收费、串换药品和耗材。
- 这是保障基金安全的重要制度安排。

3. 基金积累性（fund accumulation）

- 医疗保障要抵御疾病风险，必须**事前留有资金**。
- 基金一般分为积累型和现收现付型，但**几乎做不到完全当天收当天付**，都会有时间差，所以都会有一定积累。
- 积累是为了应对未来可能的集中支出风险。

4. 统筹互济性（pooling & mutual aid）

- 医疗保障发挥的是**互助共济功能**，运行依据**大数法则（law of large numbers）**。

- 人群越大、统筹层次越高，风险分散能力越强。
- 这是社会保障区别于商业个体保险的重要点。
- 关键词（英）：
 - legal mandatory
 - earmarked fund
 - accumulation
 - pooling / mutual aid
 - law of large numbers

五、医疗保障基金筹集的原则及渠道

（一）筹集原则

1. 与经济发展水平相适应原则

- 筹资水平要随经济发展、职工工资、物价、医保费用的实际情况**适时调整**；
- 费率一旦确定，应在一定时期内保持相对稳定，避免频繁波动，利于社会预期。

2. 以法律为依据的原则

- 医疗保障由政府通过法律法规在全社会推行，单位和个人应依法按时足额缴纳；
- 缴费标准由国家或地方性法规统一规定，**无自由选择权**。
- 医疗救助资金也以政策法规为依据筹措。

3. 保障基本的原则（basic保障原则）

- 制度目的在于居民在失去劳动能力或无力承担疾病费用时**获得基本医疗保障**；
- 社会可存在多层次医疗需求，但制度定位在“**基本**”。

4. 合理分担原则（reasonable sharing）

- 资金应由政府、单位、个人等**多方共同分担**；
- 政府提供——财政直接投入，典型如医疗救助、医疗优抚；
- 政府强制筹措——通过立法强制单位和劳动者缴费形成医保基金；
- 民间或个人自愿提供——捐赠、慈善、社会力量补充。

5. 公平互助原则（equity & mutual aid）

- 水平公平：收入相同缴费相同；
- 垂直公平：高收入多缴、低收入少缴，与支付能力挂钩；
- 尽管缴费不同，但可享受同等医保待遇 → 体现互助共济。

- 关键词（英）：
 - principle of adaptation to economic development
 - legal-based principle

- basic保障 principle
- reasonable cost sharing
- horizontal / vertical equity

(二) 筹资渠道

1. 政府财政拨款 (government fiscal appropriation)

- 方式：
 - a. 直接拨款实施某些医疗保障项目；
 - b. 财政承担社会医疗保障运行费用；
 - c. 对医疗保障缴费实行税收优惠。
- 特点：体现政府责任，是重要且较稳定的来源。

2. 雇主或雇员缴费 (税) (employer/employee contribution or tax)

- 多见于社会医疗保险；
- 多数国家采取**政府 + 雇主 + 雇员三方分担**或**雇主 + 雇员两方分担**，少数国家由一方承担；
- 征收方式有两种：
 - 缴税制 (tax-based)
 - 缴费制 (contribution-based)
- 是除财政拨款外**最主要的筹资方式**。

3. 其他筹资渠道 (other sources)

- 医疗保障基金运营管理收益**：结余资金按规定投资或运作，收益仍归基金，起到保值增值。
- 城市定制型商业医疗保险缴费**：具有“社商融合”特征，有政府支持和参与方案设计，是新型渠道。
- 社会无偿捐赠**：社会力量的慈善性补充。

- 我国的主要来源：财政 + 用人单位/个人缴费 + 适当的其他渠道。

六、医疗保障基金的筹集形式 (四种典型模式)

1. 国家税收式 (tax-based national health financing)

定义：国家通过财政征税筹集医疗保障基金，再由中央/地方政府逐级拨款，为居民提供免费或低收费医疗服务。

优势：

1. 能筹到**大量且稳定**的基金 (stable & sufficient)。

2. **社会共济能力最强**，全民分担风险。
3. **社会公平性高**，人人享有基本同等权益。
4. 计划性和费用控制能力较强，便于宏观调控。

不足：

1. 个人在筹资中的责任不够明确 → 费用意识弱，容易“多看多要”。
2. 财政负担重，且受税收政策影响大，制度独立性差。
3. 政府计划过强可能导致服务效率不高、激励不足。

2. 强制缴费式 (compulsory contribution-based)

定义：国家通过法律法规强制一定收入范围内的单位和个人按一定费率缴纳保险费。

优势：

1. 资金来源稳定、基金独立性较强，费率可调节。
2. 社会共济性较强，可大范围风险共担。
3. 权利与义务相对一致，公平性较好。
4. 由专门保险机构管理，效率较高。

不足：

1. 不同群体、参保与未参保之间待遇可能不公平。
2. 多实行“现收现付”，在人口老龄化背景下**代际矛盾突出**，抗风险能力受限。

3. 自由投保式 (voluntary insurance-based)

定义：社会成员根据自身情况自愿参加、缴费，保障水平与投保项目和保费多少直接相关，典型是商业健康保险。

优势：

1. 能满足多层次、多样化的医疗保障需求。
2. 选择度大，促进保险机构和医疗服务机构的竞争。
3. 国家财政负担较轻。
4. 权利义务对等。

不足：

1. **社会公平性差**：高危、低收入人群往往难以参保或保额不足。
2. 保险效率不高：多家机构分散经营，管理成本高。

3. 资金来源不稳定。

4. 储蓄账户式 (medical savings account based)

定义：通过法律，强制要求每个有工作的人缴存医疗基金，建立个人医疗账户，以**时间纵向分担风险**。

优势：

1. 能较好应对人口老龄化带来的基金压力，解决老龄阶段的筹资和代际负担问题。
2. 个人能直接监督账户使用，提高节约意识。
3. 政府负担轻。

不足：

1. 社会公平性较差：待遇和收入直接挂钩，低收入人群难以获得足够保障。
2. 社会共济性差：更多是在个人生命周期或家庭内部分担，难以在人群之间大范围互济。

• 关键词 (英)：

- tax-based model
- compulsory contribution model
- voluntary insurance model
- medical savings account

七、医疗保障征税与缴费的比较

(一) 征收医疗保险税的优势

1. 有利于制度的**法治化管理**，法律约束力强。
2. 税收形式本身比缴费更具**强制性**。
3. 统一税率更能体现**公平性**。
4. 有利于**全国范围内统一、提高统筹层次**。
5. 可利用现有税务体系征收，**征管成本低**。
6. 保险税专款专用，有利于公平分配和人员跨地区流动。
7. 全民缴税参保，可以**扩大覆盖面**。

征收医疗保险税的不足

1. 提高了个人负担比例。

2. 企业固定税负会抬高用工成本。
3. 统一征税和统一支付容易出现**待遇与地区经济水平不匹配**的问题。

(二) 征收医疗保障费的优势

1. 费率制定**灵活**，可根据地区与人群调整。
2. 能较好实现**权利义务对等**，强化个人与企业责任。

征收医疗保障费的不足

1. 公平程度略低于税收。
2. 法律强制力低于税收，容易出现征收乏力、欠缴问题。

- 关键词 (英):
 - medical insurance tax
 - contribution / premium
 - legal enforceability
 - nationwide pooling

八、医疗保障筹资的财务运行模式

财务模式主要解决：**钱是当天花、还是先存着、还是存一部分**的问题。

1. 现收现付制 (pay-as-you-go system)

- **定义**：以近期横向收支平衡为原则的非基金式分摊方式，当期收入基本用于当期支出。
- **优点**:
 - i. 简便易行；
 - ii. 易于纳入财政预算；
 - iii. 基金保值增值压力小。
- **缺点**:
 - i. 缺乏必要积累，抗大规模风险能力弱；
 - ii. 预测期短，稳定性差；
 - iii. 没有长期规划，面对老龄化和突发费用时压力大。

2. 完全积累制 (funded pooling)

- **定义：**又称预提分摊式，以**远期纵向收支平衡**为原则来确定费率，即“先把一生要花的大概都算出来，慢慢存”。
- **优点：**
 - i. 能形成**庞大基金积累**；
 - ii. 费率稳定；
 - iii. 权利义务联系紧密。
- **缺点：**
 - i. 计算复杂、实施难度大；
 - ii. 社会共济能力相对差；
 - iii. 基金使用和投资管理难度大；
 - iv. 制度建立初期个人/单位负担较重。

3. 部分积累制 (part funded pooling)

- **定义：**把近期横向平衡（像现收现付）和远期纵向平衡（像完全积累）结合起来的一种折中财务模式。
- **优点：**
 - i. 制度初期费率负担不大；
 - ii. 费率相对稳定；
 - iii. 贬值风险和投资压力较小。
- **缺点：**
 - i. 涉及变量多，计算烦琐；
 - ii. 不能完全避免现收现付和完全积累的缺陷。
- **关键词（英）：**
 - pay-as-you-go (PAYG)
 - funded pooling
 - part funded pooling
 - horizontal vs. vertical balance

九、需要记的重点英文词汇汇总

- medical security financing 医疗保障筹资
- funds of medical security 医疗保障基金
- social medical insurance 社会医疗保险
- fiscal appropriation 财政拨款

- compulsory contribution 强制缴费
- tax-based financing 税收式筹资
- voluntary insurance 自由投保
- medical savings account 储蓄账户式
- pooling 统筹、共济
- pay-as-you-go system 现收现付制
- funded pooling 完全积累制
- part funded pooling 部分积累制
- equity 公平
- horizontal equity 水平公平
- vertical equity 垂直公平
- legal compulsoriness 立法强制性
- earmarked fund 专款专用
- income redistribution 收入再分配
- contribution-based financing 缴费式筹资
- government-dominated financing 政府主导型筹资

第六章 医疗保险费用支付与控制

一、学习目标梳理

1. 掌握**医疗保险费用支付**的概念、分类与基本原则
2. 掌握**医疗保险需方（参保人）和供方（医药服务提供者）**的主要支付方式及特点
3. 理解**医疗保险费用控制**的基本原则与主要途径
4. 了解**医疗保险费用支付体制**的类型及我国支付方式改革的动态

二、医疗保险费用支付概述

1. 概念

- **医疗保险费用支付 (medical security expense payment)**：医保运行体系的重要环节，是医保的最基本职能之一。
- 含义可以拆成三层：
 - i. **经济补偿制度**：个人/单位/政府缴费→形成医保基金→参保人生病并获得目录内服务→医保按合同或法规给予全部或部分补偿。
 - ii. **法律契约关系**：医保经办机构、参保人、医药服务提供者三方要在医保规则或合同下履行权利义务。
 - iii. **经济激励手段**：支付方式会引导医疗资源配置、医患行为、费用控制，是最敏感的利益环节。
- 核心点：“怎么付钱”会影响“大家怎么看病、怎么收钱、费用涨不涨”。

英文关键词

- medical security expense payment 医疗保险费用支付
- economic compensation 经济补偿
- contract / legal relationship 合同/法律关系
- incentive 导向/激励

2. 医疗保险费用支付的分类

(1) 按支付时间

- **后付制 (post payment system)**
 - 先发生服务、后按项目或标准结算
 - 典型：按项目付费 (fee for service)
 - 特点：使用最广
- **预付制 (pre-pay system)**
 - 没看病之前先定额度或先付一部分，之后分期给
 - 常见于按人头付费、总额预算等

英文关键词：post payment; pre-payment / pre-pay

(2) 按支付内容

- **对医生的支付**：工资制 (salary / wage system)、按人头付费 (capitation)、RBRVS等
- **对医疗服务的支付**：门诊、住院、药品、护理分别定方式

(3) 按支付对象

- **直接支付方式**：医保→医疗机构，个人只付自付部分
- **间接支付方式**：个人先垫付→再向医保报销

(4) 按支付水平

- **全额支付**：免费医疗，医保全部承担
- **部分支付**：医保只承担合同规定的部分，个人要分担

(5) 按支付主体

- **分离式**：医保机构和医疗机构是两套体系（常见）
- **一体化方式**：筹资+服务在一个组织里，如美国HMO (health maintenance organization)

英文关键词

- direct payment 直接支付
- indirect payment 间接支付
- full payment 全额支付
- partial payment 部分支付
- HMO 健康维护组织

3. 医疗保险费用支付的原则

1. 收支平衡 (balance of revenue and expenditure)

- 支出≤基金可支付金额
- 核心是“动态平衡、可持续”

2. 权利与义务对应

- “参保才给付，不参保不给付”
- “多交多保，少交少保”
- 体现公平前提下的激励

3. 符合医疗保险规范

- 必须在医保规定范围内：药品目录、诊疗项目、服务设施、病种
- 超范围医保不付

4. 有限支付

- 不超过实际发生费用
- 为了防止滥用，要让个人分担一部分

英文关键词

- balance 收支平衡
- entitlement vs obligation 权利与义务
- coverage / benefit package 支付范围
- limited payment 有限支付

三、医疗保险费用支付体制

这是从“全国怎么组织付钱”的角度说的，比前面那些“按项目、按人头”更宏观。

1. 集中统一支付模式

- 基金集中到一个付款人（单一支付人，single payer）
- 政府主导、计划性强、控制总费用能力强、管理成本低
- 典型：英国（中央）、加拿大（省级）、瑞典（地方）

2. 比较集中的准统一支付模式

- 基金多渠道筹集，但最终集中到社会医保机构
- 医保机构和医疗服务提供者协商统一标准
- 控制总量、价格谈判力强

- 典型：德国、法国、荷兰

3. 分散独立的支付模式

- 多个支付人并存，公私保险共存
- 优点：参保人选择多
- 缺点：支付分散、控制点多，费用不好控，管理成本高
- 典型：美国

英文关键词

- single-payer 单一支付人
- social health insurance 社会医疗保险
- multiple payers 多元支付人

四、医疗保险需方费用支付方式（对参保人的分担设计）

重点是：起付线、共同付费、最高限额、混合。

1. 起付线方式（deductible）

- 医保先设一个最低支付标准
- **低于起付线：个人全负担**
- **超过起付线：医保再开始支付**
- 作用：增强费用意识；减少小额报销；保大病
- 难点：起付线怎么定

关键词：deductible 起付线/免赔额

2. 共同付费方式（cost-sharing）

- 医保和个人按比例分担
- 简单、直观、好操作
- 可用变动比例（花得多自付比例变大）
- 难点：比例怎么定

关键词：cost-sharing；co-payment；co-insurance

3. 最高限额方式（ceiling）

- 医保设一个年度或阶段的封顶线
- 低于封顶线：医保按规定支付
- 超过封顶线：个人或单位再负担
- 作用：保障基本医疗、限制过度高额需求、自我管理

关键词：ceiling / maximum payment / cap

4. 混合支付方式

- 起付线+共付+封顶线综合用
- 现实中最常见，因为单一方式都有缺陷

5. 我国改革思路

- 分担比例要跟参保人承受能力匹配
- 多种方式综合
- 强化个人账户的激励作用

五、医疗保险供方 费用支付方式（对医疗机构/医生怎么付）

这一节是全章内容量最大的，要记清楚“10大类方式 + 各自优缺点”。

（一）按服务项目支付方式（Fee for Service, FFS）

1. 概念：对每一个医疗服务项目**逐项定价+逐项结算**
2. 优点：
 - 最直观、最传统
 - 服务多、收入多，激励提供服务
3. 缺点（重点！）：
 - 属于**后付制**，只能事后管账
 - 容易诱导需求：多检查、多用药、延长住院、用高新技术
 - 管理成本高，要逐项审核
 - **最容易导致医疗费用不合理增长**

关键词：fee for service (FFS); itemized payment

（二）按工资标准支付方式（wage system / salary）

1. 概念：医保机构或所属机构按医务人员的时间、职称、数量、质量等**定期发工资**
2. 优点：收入稳定
3. 缺点：
 - 经济刺激不足 → 积极性、效率可能不高
 - 可能把重病人转走，减少成本

关键词：salary；wage system

（三）按人头支付方式（capitation）

1. 概念：按**参保人数 × 人均定额 × 时间段**，医保预先付一笔钱给定点机构；期间看病不再另收费
2. 特点：收入与服务人数相关
3. 缺点/风险：
 - 医疗机构可能**少服务、少用高技术**来省钱
 - 可能拒收重症、让病人排队
 - 减少就医选择性

关键词：capitation；per capita payment

（四）按服务人次支付方式

1. 概念：对每一门诊人次或住院人次设一个标准，最后按人次×标准结算
2. 优点：简单
3. 缺点：
 - 容易拆分成多次就诊（分解服务）
 - 不同机构、不同病种差异大，标准难定
 - 仍可能降质量省成本

关键词：per visit payment；per case (但这里更偏“人次”)

（五）按以资源为基础的相对价值标准支付（RBRVS）

1. 概念：resource-based relative value scale

- 按投入的资源（医生劳动、专科成本、培训机会成本等）算出一个“相对价值”
- 再通过转换因子变成价格
- 公式： $RBRVS = TW \times (1+RPC) \times (1+AST)$
 - TW：医生劳动总投入
 - RPC：专科相对成本指数
 - AST：按普通外科为标准的专科培训机会成本分摊指数

2. 优点：

- 能比较不同服务的资源消耗 → 补偿更合理
- 医生劳务价值与药品检查脱钩 → 减少过度检查
- 有利于改善不同专科补偿不公平

3. 缺点：

- 没充分考虑患者疾病严重度、医生能力、治疗效果
- 教学医院收重症多，会吃亏
- 制定过程要大量数据，管理成本高

关键词：RBRVS；relative value；conversion factor

（六）按住院床日支付方式（per diem system）

1. 概念：先测算出“每床日支付标准”，再按住院天数×标准来付

2. 优点：

- 有预算性质，促进医院降成本
- 审核简单、管理成本低

3. 缺点：

- 医院可能**故意延长住院天数**
- 病情轻的更受欢迎，重症被转走
- 可能减少必要服务

关键词：per diem；bed-day payment

（七）按疾病诊断相关分组支付（DRG，diagnosis related group）

1. 概念三层含义：

- 是**病例分类方案**
- 以诊断为基础，考虑年龄、手术、有无并发症、合并症
- 把“治疗活动”跟“费用”连起来 → 为预付费打基础
- 付费时：不看你实际花了多少，而是看你这个病例被分到哪个DRG组 → 按该组标准付

2. 优点：

- 控制费用上涨
- 促进医疗质量和病案质量
- 推动医院规范化管理、绩效考核

3. 缺点：

- 医院可能**夸大病情、提高编码（upcoding）**
- 可能诱导手术、缩短住院后再次入院
- 可能减少必要服务、推重症
- 管理和技术要求高，成本较高

关键词：DRG；case-mix；upcoding

（八）按资源利用组III支付（RUG-III）

1. 概念：resource utilization groups, version III

- 主要用于**慢性病、康复病种**
- 依据临床特征+资源利用程度分组
- 同组患者服务需求接近 → 费用接近

2. 相比DRG的优势：

- 更考虑慢性病人的生活功能、心理需求
- 成本考虑更全面（含人事费）
- 能控制过度供给
- 能避免重症出不了院、轻症又不该住的情况

3. 缺点：

- 实际分组操作复杂，一个人可能符合多个组 → 合并时易浪费

关键词：RUG-III；long-term care payment

（九）按病种分值支付（DIP，diagnosis-intervention packet）

1. 概念：是**中国本土化、基于大数据**的一套医保付费与管理体系

- 核心是“疾病诊断+治疗方式” → 形成客观分类

- 根据全地区的病例数据形成**每个病种的分值**
- 在总额预算下，用“总分值×分值点值”来结算
- 不再按项目付费，而是按标准化分值付

2. 优点：

- 控制费用
- 促进医院精细化管理、服务模式转变
- 有利于分级诊疗
- 对数据要求比DRG低，更易推广

3. 缺点：

- 分类和分值标准还要完善
- 等级系数怎么设还难
- 对医保经办要求提高

关键词：DIP；case-based payment（China-oriented）

（十）总额预算方式（global budget）

1. 概念：医保与医院事先协商**年度总额**，并包干使用

2. 特点：

- 服务量增多，医院收入也不一定增
- 预算一般每年调整
- 确定预算要考虑：医院规模、质量、地区人口、死亡率、教学性质、设备情况、上年结余/赤字、通胀等

3. 优点：

- 控制医疗费用总量效果好
- 促使机构降成本、提高效率
- 简化结算，减少医保管理成本

4. 缺点：

- 可能降低服务积极性、影响服务质量、出现住院难
- 可能影响新技术应用
- 超预算后怎么分担实际操作有难度

关键词：global budget；prospective budget

六、医疗保险费用控制

1. 基本原则

- 控制医疗费用过快增长
- 保证基金安全与制度可持续
- 在控制的同时要保证必要的医疗服务可及

2. 对**需方（参保人）**的费用控制途径

- 通过起付线、共付、封顶线等分担机制，限制不必要的就医
- 合理设置个人账户，增强个人责任
- 引导参保人合理就医

3. 对**供方（医疗机构和医务人员）**的费用控制途径

（1）控制服务供给量

- 限制资金预算
- 医疗经费包干
- 控制医疗机构规模和数量
- 限制大型设备的配置与使用

（2）控制卫生人力资源

- 合理配置医务人员
- 引导医务人员向基层流动

（3）增加非住院保健服务

- 住院费用是大头 → 增加社区卫生服务中心、健康管理中心、老年护理院、临终关怀、夜间医院、家庭病床、日间病房、日间手术等 → 减少住院费用

（4）加强医药机构监管

- 制定基本用药范围、基本诊疗项目和诊疗常规
- 调整不合理的服务价格和收费结构
- 建立定点机构的考核与动态准入退出
- 处罚违规机构和人员，严重的取消医保服务资格

（5）完善费用支付方式

- 单一支付方式都会带来行为扭曲 → 要综合使用
- 支付方式要跟医院补偿机制、内部管理结合，才能让医院愿意配合医保

英文关键词

- cost containment 费用控制
- utilization control 服务利用控制
- provider monitoring 供方监管
- essential services 基本医疗服务
- day surgery 日间手术

七、我国医疗保险费用支付改革的特点（从课件总结出来的方向）

1. **从单一向多元混合发展**：按项目、按病种、总额预算、DRG/DIP并行
2. **从事后结算向事前约束转移**：预付制、总额预算、按人头
3. **从分散支付向适度集中**：提高医保话语权、统一支付标准
4. **支付方式和监管同步**：推DRG/DIP的同时要提高病案质量、信息化水平
5. **更注重基金安全和控费效果**：支付方式要能真正“控得住”

重点英文单词汇总（便于你背）

- medical security expense payment 医疗保险费用支付
- post payment system 后付制
- pre-pay system 预付制
- deductible 起付线
- cost-sharing / co-payment 共同付费
- ceiling / cap 封顶线
- fee for service (FFS) 按服务项目付费
- capitation 按人头付费
- per diem 按床日付费
- diagnosis related group (DRG) 疾病诊断相关分组
- resource utilization groups (RUG-III) 资源利用组III
- diagnosis-intervention packet (DIP) 按病种分值付费

- global budget 总额预算
- single-payer 单一支付人
- health maintenance organization (HMO) 健康维护组织
- resource-based relative value scale (RBRVS) 资源为基础的相对价值标准
- provider 医疗服务提供者
- cost containment 费用控制

第十二章 国外医疗保障制度

一、学习目标

1. 掌握**医疗保障制度的主要模式及其特点**，理解不同制度的绩效差异。
2. 理解不同医疗保险模式在**筹资来源、服务提供与管理、保障范围、付费方式**上的差别。
3. 了解**典型国家医疗保障体系的构成与特点**，包括英、德、法、日、美、新加坡等。
4. 能够对**国外医疗保障制度的改革**进行概括，并提出**对我国的启示**。

本节重点英文单词：

- medical security / medical保障
- health care system 医疗卫生系统
- medical insurance 医疗保险
- national health service (NHS) 国家卫生服务制度
- social health insurance (SHI) 社会医疗保险
- coverage 覆盖率
- financing / funding 筹资
- provider 服务提供者
- benefit package 保障范围

二、第一节 医疗保障制度概述

1. 医疗保障制度的概念

- 含义：国家或社会在居民**患病或伤害后**给予其**医疗服务或经济补偿**的一种社会保障制度。
- 实质：通过制度性安排，解决“生了病怎么办、谁出钱、能报多少、何时能享受”的问题。
- 范围：它是**各类国家卫生服务制度、医疗免费制度、医疗救助制度、医疗保险制度**的统称，是健康保障制度的**狭义称谓**。

2. 医疗保障的内涵——三个核心问题

课件说要回答三个“谁/什么/何时/多少”的问题：

1. **谁支付？**（资金来源与筹资主体）
2. **谁得到？**（人群覆盖，即哪些人能享受）
3. **得到什么、何时得到、得到多少？**（待遇水平与保障范围）

各国正是因为对这三个问题的回答不同，才形成了不同的医疗保险模式。

英文提示：

- who pays
- who is covered / who gets it
- what to get & when & how much

3. 医疗保障制度的总体安排

世界上大多数国家的医疗保障制度=国家医疗保障 + 补充医疗保险两大块。

(1) 国家医疗保障（基本医疗保障）

- 是**主体、核心**。
- 主要形式只有两种：
 - i. **社会医疗保险**（Social Health Insurance, SHI）
 - ii. **国家卫生服务制度**（National Health Service, NHS）
- 还包括**医疗救助**：对社会弱势群体给予的政府兜底援助。

(2) 补充医疗保险

- **企业补充医疗保险**：企业在参加社会医保基础上再提高职工抗风险能力。
- **商业医疗保险**（Commercial Health Insurance）：投保人与保险公司签约，按合同付费，按合同给付。
- **家庭保障**：虽非社会性制度，但在发展中国家仍是重要的医疗保障来源。

本节重点英文单词：

- basic medical insurance 基本医疗保险
- national health service 国家卫生服务
- medical assistance 医疗救助
- supplementary / complementary insurance 补充医疗保险
- commercial health insurance 商业医疗保险
- social assistance 社会救助

三、第二节 医疗保障制度分类

课件把国外主要的医疗保障模式分成**四大类**：

1. 国家医疗保险模式（也可理解为政府办的、税收型、NHS型）
2. 社会医疗保险模式（欧洲典型的法德日模式）
3. 商业医疗保险模式（以美国为代表的市场型、多支柱型）
4. 储蓄医疗保险模式（新加坡为典型，强制个人医疗储蓄）

（一）国家医疗保险模式

1. 概念

- 又称**政府医疗保险模式**。
- 核心：**政府通过税收筹资**，通过财政预算把钱拨给医疗机构，由其向居民提供**免费或低收费**服务。
- 典型国家：**英国、瑞典**；还包括加拿大、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、丹麦、大部分北欧国家；我国50年代至90年代末的传统公费医疗也属于此类。

2. 特点

1. **筹资来源主要是税收**，筹资主体是政府，渠道依赖财政预算。
2. **医疗服务具有一定的国家垄断性**，政府把基金划拨给公立医疗机构或以合同形式购买民间服务。
3. **覆盖范围广，一般实现全民覆盖**，公民享受保险范围内的免费或低收费服务。
4. **政府计划管理**，对医疗资源与基金配置进行调控，卫生部门直接参与医疗机构建设与管理。
 - 优点：公平性好、覆盖面广、费用可控。
 - 缺点：容易出现效率低下、等候时间长。

本类重点英文单词：

- tax-based financing 税收筹资
- government-run 政府举办
- universal coverage 全民覆盖
- budget allocation 预算拨款
- publicly owned providers 公立服务提供者

(二) 社会医疗保险模式

1. 概念

- 通过**国家立法**，按**强制性社会保险原则**筹集和使用医疗保险基金，以保证全体成员**公平获得适宜的医疗卫生服务**的一种制度。
- 典型在**德国、日本、法国、荷兰**等。

2. 三大特征

1. **强制性** (compulsory)：法律规定必须参加。
2. **依据社区风险费率筹资** (risk-based / community-rated)：按一定费率筹资。
3. **社会互助共济** (mutual assistance / solidarity)：通过社会统筹实现风险分担。

3. 基金筹资来源

- 一般由**雇主和雇员共同缴纳**，但比例因国而异。
- 以德国为例：资金来源包括投保人、雇主和第三人的保险费、国家补贴及其他收入；费率由各医疗保险规章规定。

4. 社会医疗保险基金的构成

1. **社会统筹基金**：统一支配，用于报销参保人生病就医费用。
2. **医疗储蓄账户/个人账户基金**：按规定由个人账户开支的医疗费用。
3. **风险储备金**：应对突发传染病、基金赤字，一般不超过保险费的10%。
4. **预防保健费**：用于参保人健康维护、预防服务的费用。
5. **管理费**：医保机构日常运行、项目开发的费用。
→ 可以看出社会医保不仅付治疗，还考虑预防、管理和风险调节。

本类重点英文单词：

- social health insurance (SHI) 社会医疗保险
- compulsory insurance 强制保险
- pooled fund / social pooling 社会统筹
- individual account 个人账户
- risk reserve 风险储备
- employer contribution 雇主缴费
- employee contribution 雇员缴费

(三) 商业医疗保险模式

1. 概念与特点

- 又称**市场医疗保险模式**。
- 按市场规则经营，把医疗保险当作一种**特殊商品**进行买卖，主要通过**市场机制**筹资和提供服务。
- **美国是典型**：以**商业健康保险为主体层 + 公共医疗保障为保底层**，市场运作为主，政府保障为辅，呈**多支柱、多部门、层次化**特点。

2. 美国商业医疗保险的构成

1. **非营利性商业医疗保险**：最典型是“蓝十字-蓝盾”(Blue Cross & Blue Shield)，是美国最大非营利健康保险组织。
2. **营利性商业健康保险**：包括团体、补充和个人健康保险。
3. **管理型医疗保险 (managed care)**：包括
 - HMO (Health Maintenance Organization) 健康维护组织
 - PPO (Preferred Provider Organization) 优先选择提供者组织
 - POS / 定点服务组织等管理型医疗通过“限定服务提供者 + 费用控制”来降低成本。

本类重点英文单词：

- commercial health insurance 商业健康保险
- managed care 管理式医疗
- HMO / PPO / POS
- for-profit / non-profit 盈利/非盈利
- multi-pillar system 多支柱体系

(四) 储蓄医疗保险模式（以新加坡为例）

1. 概念与特点

- 是一种**强制医疗储蓄**形式。
- 通过立法，强制劳方或劳资双方缴费，以**个人名义建立保健储蓄账户**，用于支付本人及家庭成员的医疗费用。
- 典型国家：**新加坡**，还有斯里兰卡、马来西亚、印度尼西亚等。

2. 新加坡模式的主要特点

1. 筹资方式：法律强制储蓄
2. 筹资责任：个人为基础
3. 基金积累：纵向积累，账户可保值增值
4. 有补充保险：自愿参加
5. 缴费按年龄差别费率，由雇主和雇员分摊，存入中央公积金(CPF)下的保健储蓄账户。
6. 账户可设计**总额封顶、最低限额、余额继承**等规则。
7. 在储蓄账户之外还有两层：
 - 帮助付大病费用的**统筹性低价医疗保险**（类似 MediShield）
 - 面向无支付能力者的**医疗救助基金**（Medifund），构成“安全网”。

本类重点英文单词：

- medical savings account (MSA) 医疗储蓄账户
- Central Provident Fund (CPF) 中央公积金
- MediShield（大病统筹层）
- Medifund（医疗救助基金）
- compulsory saving 强制储蓄

四、第三节 国外医疗保障制度模式比较与评价

1. 比较的三个维度（WHO 推荐）

1. **覆盖率 Coverage**：是否全民覆盖。
2. **财务风险分担 Financial risk protection**：能否减轻个人因病致贫、过高自付。
3. **卫生服务可及性 Accessibility**：能否真正获得服务、排队时间、地理与经济可及性。

2. 各模式的覆盖情况

- **国家医疗保险模式**：一般为**全民覆盖**。
- **社会医疗保险模式**：覆盖率也很高，如日本、英国100%，法国和德国约99.9%。
- **商业保险为主的美国**：覆盖率最低，约91.4%，存在未参保人群。

3. 个人自付与费用控制

- **国家医疗保险**：多为**免费医疗**或象征性收费。
- **社会医疗保险**：个人自付比例一般**20%~30%**。

- 美国：设定起付线和分段自付，住院时间越长，个人负担越重，说明其**费用分担压力大**。

4. 就医行为管理

- 日本、法国：**就医自由**。
- 英国：有**GP（全科医生）守门人制度**，需要转诊。
- 美国：是否限制取决于参保的保险组织类型，HMO 限制更多。

5. 绩效评价指标

课件强调几个常见指标：

1. 卫生服务的公平性与可及性

- 英国、加拿大把卫生服务视作社会福利，公平性好。
- 美国因未全民覆盖，在筹资公平和需求满足方面均不及其他国家。
- 日本在筹资和覆盖率方面也体现了较好的公平性。

2. 健康状况

- 日本卫生投入相对低，但预期寿命、婴儿死亡率等指标最好。
- 美国投入世界最高，但预期寿命等健康指标落后，说明**投入产出比低**。

3. 费用控制

- 英国费用控制最好，投入与人均费用低。
- 德国、加拿大略高于英日，远低于美国。
- 美国投入最高、控制最差。

4. 效率指标

- 课件提到：美国模式效率指标较好，其次国家医疗保险，然后社会医疗保险。

5. 自主性与反应性

- 社会医疗保险在健康状况方面好，但在尊重、沟通和保密性方面不如国家医疗保险。
这里实际上提示了“没有一个模式是完美的，要在公平、效率、选择、自主之间权衡”。

本节重点英文单词：

- coverage rate 覆盖率
- financial protection 财务风险保护
- accessibility 可及性
- gatekeeper 守门人
- out-of-pocket payment (OOP) 个人自付
- performance evaluation 绩效评价

五、第四节 国外医疗保障制度的改革

1. 欧洲各国改革

(1) 英国NHS改革

- 问题：医疗服务效率低。
 - 措施：通过引入**内部市场 (internal market)**，让购买和提供分开，增强竞争和激励。
 - 时间线：
 - 1991年开始改革；
 - 1993年在社区医疗推行；
 - 1997年提出以更整合的NHS替代内部市场；
 - 2013年启动新的改革计划；
 - 2018年前推动医院“无纸化”、电子病历联网，提高系统效率。
- 关键词：市场机制、分权、信息化。

(2) 社会医疗保险国家的改革

- 德国、法国、荷兰等的共同点：引入**按疾病诊断相关分组 (DRG) 支付方式**，用支付制度改革倒逼效率。
 - 欧洲各国对美国DRG做了本土化改造：
 - 英国、荷兰不直接用美版DRG，而是**参考后自制分类**；
 - 瑞典、挪威做了修改，形成**Nord-DRG**。
- 说明支付方式改革是国际共识：从按项目付费(Fee-for-service)走向按病种、按人头、打包付费。

2. 日本医疗保障模式改革

- 日本实行**全民医疗保障**，医疗机构以**非营利机构**为主，公立约18%。
 - 医疗机构有**明确的功能划分**，机构间靠转诊和合作提供连续服务。
 - 法律禁止“混合诊疗”(保险+非保险同时收)，要求按医保目录支付。
 - 支付方式：
 - 急性期：用**DPC (Diagnosis Procedure Combination)**，类似DRG；
 - 慢性期：仍以**按项目付费**为主。
 - 药品：政府统一定价，医药“半分家”，物流集约化，信息系统强大；有消费者监督。
 - 医疗服务技术评估：采用**RBRVS**标准制定收费。
- 日本特点：监管强、全民保、费用低、健康指标好。

本节重点英文单词：

- internal market 内部市场
- DRG (Diagnosis Related Groups) 疾病诊断相关分组
- DPC (Diagnosis Procedure Combination) 日本版诊断程序组合
- RBRVS (Resource-Based Relative Value Scale) 资源基础相对价值体系
- e-health / electronic medical record 电子病历

六、第五节 国外医疗保障制度改革对我国的启示

课件最后一节主要是“看别人怎么做 → 看他们遇到的问题 → 总结趋势 → 给我国的借鉴”。可归纳为几条逻辑：

1. 国外运行中的主要问题

- 成本持续上涨
- 人口老龄化导致医疗需求增加
- 技术进步推高费用
- 公平与效率的张力始终存在
- 公立部门效率不高、等待时间长

2. 改革的共同趋势

- 支付方式的改革：向DRG/DPC、人头付费、打包付费转变
- 引入竞争机制和购买服务机制
- 信息化、数字化、电子病历、无纸化
- 在保障基本的同时，鼓励多层次保障（补充+商业）

3. 对我国的借鉴意义（可写作要点）：

- 坚持**基本医疗保障的主体地位**，实现广覆盖
- 完善**多层次医疗保障体系**，发挥企业补充和商业保险的作用
- 改革**医保支付方式**，提高基金使用效率
- 加强**对弱势人群的医疗救助**，实现托底
- 加强**政府监管和信息化建设**，提高医疗服务质量与效率
- 注意**公平与效率并重、政府与市场有效结合**

（如果你要写课程论文或作业，可以把这一节扩成“问题—措施—成效—启示”四段式。）

本节重点英文单词：

- multi-level medical security system 多层次医疗保障体系
- payment reform 支付方式改革
- cost containment 费用控制
- medical assistance 医疗救助

- universal basic coverage 全民基本覆盖

统一汇总：重点英文单词（可抄到最后一页）

- medical security system 医疗保障制度
- national health service (NHS) 国家卫生服务制度
- social health insurance (SHI) 社会医疗保险
- commercial health insurance 商业医疗保险
- medical savings account (MSA) 医疗储蓄账户
- universal coverage 全民覆盖
- financing / funding 筹资
- gatekeeper 守门人
- out-of-pocket payment (OOP) 个人自付
- DRG (Diagnosis Related Groups) 按病种分组付费
- DPC (Diagnosis Procedure Combination) 日本诊断程序组合
- RBRVS 资源基础相对价值体系
- managed care 管理式医疗
- HMO / PPO 管理式医疗组织
- cost containment 成本控制
- performance evaluation 绩效评价
- medical assistance 医疗救助
- supplementary insurance 补充保险
- multi-pillar system 多支柱体系

第十三章 我国多层次医疗保障体系

一、学习目标

1. 掌握我国多层次医疗保障体系的**基本结构与构成主体**。
2. 理解城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的**概念、目标、原则、制度框架与发展现状**。
3. 分析当前两大基本医保制度面临的**主要挑战与未来发展趋势**。
4. 了解补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠与医疗互助在体系中的**位置与作用**。

(核心关键词: medical security system, basic medical insurance, multi-level system)

二、我国多层次医疗保障体系概述

1. 政策背景

- 2020年3月《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》明确提出,要**全面建成**“以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系”。这是当前阶段我国医疗保障制度顶层设计的政策依据。

(英文可记: “Opinions on Deepening the Reform of the Medical Security System”, medical assistance as the bottom line)

2. 多层次医疗保障体系的构成 (按举办主体)

按照“谁来办/谁出面做”划分,分为**四个层次**:

1. 第一层: 国家举办的基本医疗保障制度

- 核心是**基本医疗保险** (basic medical insurance), 含:
 - 城镇职工基本医疗保险
 - 城乡居民基本医疗保险 (由原城镇居民医保+新农合整合而来)
- 还包括与基本医保配套的**大病保险** (catastrophic medical insurance) 与**医疗救助** (medical assistance)。

2. 第二层: 用人单位举办的制度

- 典型是**企业补充医疗保险**（supplementary medical insurance organized by employers），国家有税收等政策支持。
3. **第三层：以个人购买为主的商业健康保险**
- 市场化、营利性，保险人以盈利为目的，为被保险人的合理必要医疗费用提供补偿。
4. **第四层：社会和市场力量形成的慈善捐赠与医疗互助**
- 以社会捐献、网络众筹、慈善基金、医疗互助组织为主，体现社会互助性。
- 城镇与农村在“层次结构”上**没有本质差别**，都是这四层。

3. 多层次医疗保障体系的基本内容

(1) 基本医疗保障

1. **基本医疗保险**（basic medical insurance）
 - 体系来源：城镇职工医保、城镇居民医保、新型农村合作医疗三大块。
 - 2016年《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》提出整合城镇居民医保和新农合，建立统一的**城乡居民基本医疗保险**（urban-rural resident basic medical insurance）。
2. **大病保险**
 - 目前由三类制度构成：城乡居民大病保险、职工大额医疗费用补助、公务员医疗补助。
 - 作用：对年度医疗费用**超过封顶线以上的部分**进行**二次报销**，是“再补一层”。
3. **医疗救助**（medical assistance）
 - 体系“网底”。服务对象：无力参保或参保后仍无力承担自付费用的**城乡贫困人口**。
 - 资金来源：以财政为主，也可吸纳社会捐助、公益彩票等。
 - 补贴形式：
 - 全额补贴：特困人员
 - 定额补贴：低保对象、返贫致贫人口等

(2) 企业补充医疗保险

- 定义：在参加基本医保基础上，为解决基本医保+大额医疗补助以外费用负担，由国家给予政策支持、企业自主举办或参加的补充性医疗保险。
- 两种主要情形：
 - i. 企业在税收优惠下**自愿举办**的补充性医保（福利性明显）；
 - ii. 企业统一为职工购买的**商业健康保险（团险）**，属市场化福利。
- 作用：缩小基本医保待遇与实际医疗消费之间的差距。

(3) 商业健康保险（commercial health insurance）

- 特点：单位和个人自愿参加，保险人以营利为目的，补偿合理必要医疗费用。
- 作用：基本医保只能“保基本”，商业健康保险可**满足不同群体差异化医疗需求**。
- 常见险种：普通医疗保险、住院医疗保险、手术医疗保险、意外伤害医疗保险等。

(4) 慈善捐赠与医疗互助

- 法律基础：《中华人民共和国慈善法》（2016）已有提及。
- 现实特点：互联网众筹增长快，但整体**政策支持仍不足、规范性不够**。

4. 我国多层次医疗保障体系的特征

1. **覆盖人口广泛**：坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”，基本实现人人享有基本医疗保障。
2. **保障模式多样化**：职工医保、城乡居民医保都属于基本医疗保险，但支付方式、目录等可不同。
3. **资金来源多渠道**：政府、单位、个人共同筹资；职工医保由单位和职工共同缴纳。
4. **强制与自愿相结合**：基本层面以强制参保为主，上层补充与商业保险以自愿为主，符合国情。

三、城镇职工基本医疗保险制度

1. 发展历程

- 计划经济时期：以**劳保医疗制度**（企业负责）和**公费医疗制度**（财政负责）为主。
- 1994年“两江试点”（镇江、九江）开始城市职工医疗保障制度改革。
- 之后近30年不断完善：扩大覆盖、提高待遇、规范基金管理。
（英文：labor protection medical system, public-funded medical care, pilot reform）

2. 制度框架

(1) 目标与基本原则

- 目标：在社会主义市场经济条件下，根据财政、企业和个人承受能力，建立**保障职工基本医疗需求**的社会医疗保险制度。
- 原则：
 - i. 水平与生产力发展水平相适应；
 - ii. 城镇所有用人单位及其职工都要参加，**属地管理**（local-based administration）；
 - iii. 用人单位和职工**共同缴费**；
 - iv. **社会统筹+个人账户**相结合（social pooling + individual accounts）。

(2) 覆盖范围

- 强制覆盖所有城镇用人单位及职工：企业（国企、集体、外资、私营）、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位等**正规就业人群**。
- 到2020年累计覆盖约3.44亿人，但与4.3亿城镇就业人口相比仍有约1.2亿未被覆盖。

(3) 资金筹集

- 单位缴费率约为职工工资总额的**6%**左右；
- 个人缴费率一般为本人工资收入的**2%**；
- 可随经济发展水平适当调整。

(4) 统筹基金与个人账户管理

- 基金由****统筹基金（pooling fund）和个人账户（individual account）****构成。
- 个人缴费全部进入个人账户；单位缴费按比例划入统筹基金和个人账户（个人账户约30%）。
- 2021年国务院《指导意见》改革：**个人缴费全部计入个人账户，单位缴费全部进入统筹基金，并拓宽个人账户使用范围、允许家庭共济**。这实际上是在强化门诊共济、弱化过度分散的小账户。

(5) 基金管理

- 基金纳入财政专户，专款专用，收支平衡；
- 有社会保险经办机构负责征缴、管理、支付；
- 有审计和社会监督机制；
- 强调**以收定支**，防止挪用。

(6) 保障待遇

- 实行**目录管理**：药品目录（drug list）、诊疗目录（treatment list）、医疗服务设施目录。
- 实行“统账结合”：
 - 个人账户：主要用于**小病、门诊**；
 - 统筹基金：主要保**住院和门诊大病**。
- 起付标准：原则上控制在当地职工年平均工资的**10%**左右；
- 最高支付限额：原则上控制在当地职工年平均工资的**6倍**左右；
- 起付线以下由个人账户或个人自付；起付线以上至封顶线以下由统筹基金为主、个人分担为辅。
- 有定点医疗机构和定点零售药店的协议管理办法（2021年专门出台暂行办法）。

3. 制度成效

1. **覆盖面快速推进**：进入发展成熟期，向个体工商户、灵活就业人员、特殊困难群体拓展。
2. **基金收支规模稳定上升**：2000年收入170亿元→2020年收入1.5万亿元以上，累计结余大幅增长。
3. **待遇水平提高**：住院费用基金支付比例从早期的67%提高到2020年约80%，并实现全国跨省异地就医住院费用直接结算，4.4万家定点医疗机构联网。

4. 主要挑战

1. **参保面与参保质量不够**

- 仍有未参保人群；
- 存在重复参保、断保、停保；
- 信息系统和对新就业形态人员的参保方式有待完善。

2. 医疗费用增长过快，基金可持续性压力大

- 医疗总费用、次均住院费用持续上升；
- 人口老龄化导致退休人员基金利用率高，未来有“入不敷出”风险。

3. 对医疗机构的监督能力不足

- 医疗机构公益性淡化、逐利行为→过度医疗、看病贵、医患矛盾；
- 需要更强的第三方监督和信息化监管。

5. 发展趋势

1. **扩大参保范围，提高参保质量**：完善灵活就业人员参保方式、清理虚假重复参保、建立数据共享。
2. **完善筹资机制**：探索多渠道筹资、适当调整单位和个人费率，促进社保与商保融合。
3. **健全管理制度**：建立独立第三方监督、完善信息系统、推进省级统筹、扩大基金共济范围、统一结算网络。

四、城乡居民基本医疗保险制度

1. 制度的产生与演变

(1) 新型农村合作医疗（new rural cooperative medical scheme, NRCMS）

- 传统合作医疗起于上世纪50年代后期，70年代普及，80年代后期基本解体。
- 2002年中央提出到2010年基本建立农村合作医疗制度；
- 2003年《意见》明确：新农合是**政府组织、引导、支持**，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以**大病统筹为主**的医疗互助共济制度。

(2) 城镇居民基本医疗保险制度（urban resident basic medical insurance）

- 2007年国务院发布试点指导意见，覆盖**非从业居民**（如儿童、学生、老年无业居民等）。
- 以政府主导，居民个人（家庭）缴费为主、政府适当补助，体现**缴费与待遇相一致**。
- 到2011年，基本实现了制度框架上的**全民医保**。

(3) 城乡居民基本医疗保险的形成

- 2016年国务院意见：整合城镇居民医保和新农合，建立统一的城乡居民医保制度。

- 2019年又提出到2022年基本建立城乡融合发展体制机制，医保制度的城乡一体化是其中重要内容。
→ 整合的目的：**保障更公平、管理更规范、资源利用更有效。**

2. 制度框架

(1) 目标与基本原则

- 目标：在全国范围内建立起统一的城乡居民医保制度，促进全民医保可持续发展。
- 原则：
 - i. 统筹规划、协调发展
 - ii. 立足基本、保障公平
 - iii. 因地制宜、有序推进
 - iv. 创新机制、提升效能

(2) 覆盖范围

- 覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的**所有城乡居民**；
- 农民工、灵活就业人员依法参加职工医保，确有困难的可按当地规定参加居民医保；
- 要实现“应保尽保”，同时避免重复参保。

(3) 筹资政策

- 个人缴费+政府补助为主，鼓励集体、单位和社会组织资助。
- 按照基金收支平衡合理确定筹资标准，逐步建立与经济社会发展水平和承受能力相适应的**动态调整机制**。

(4) 保障待遇

- 原则：**保障适度、收支平衡**，均衡城乡待遇，逐步统一保障范围和支付标准。
- 基金主要用于住院和门诊医药费用支付；
- 政策范围内住院费用支付比例保持在**75%左右**；
- 完善门诊统筹，提高门诊保障水平，缩小政策范围内支付比例与实际支付比例的差距。

(5) 医保目录

- 统一城乡居民医保药品目录和医疗服务项目目录，实行**分级管理、动态调整**；
- 遵循临床必需、安全有效、价格合理、技术适宜、基金可承受的原则；
- 在原有城镇居民医保和新农合目录基础上，适度增减。

(6) 定点医疗机构管理

- 统一城乡居民医保定点机构管理办法；
- 公立、非公立医疗机构同等对待；
- 建立动态准入退出机制，统筹地区管理机构负责准入与监管，省级负责原则与监督。

(7) 基金管理

- 基金纳入财政专户，实行“收支两条线”；
- 独立核算、专户管理；
- 以收定支、收支平衡、略有结余，确保及时足额拨付；
- 严禁挤占挪用。

3. 制度成效

1. **覆盖迅速推进**：城乡居民医保整合后参保人数增加，风险共济能力提高。
2. **待遇整体优化**：整合后往往实行“目录就宽不就窄、待遇就高不就低”，农民群体报销范围明显扩大。
3. **统筹层次提高、就医更便利**：市（地）级统筹、鼓励省级统筹，同时全国异地就医结算系统联通，参保人就医选择范围扩大、权益可携性增强。
4. **效率与服务并存问题**：机构合并减少重复建设、节约管理资源，但转轨期间可能出现信息衔接不畅、服务断接现象。

4. 发展中的主要挑战

1. **碎片化的管理体系**：城镇职工、城镇居民、新农合、医疗救助等长期分割管理，造成衔接不畅、资源配置失衡、效率低。
2. **经办管理力量不足**：覆盖人口大、人员编制少、专业能力不足（如价格谈判、数据处理、医药管理等）。我国医保经办人员与参保人员比例明显低于很多国家。
3. **基金可持续性不足**：
 - 整合减少了重复参保、重复补贴→收入相对减少；
 - “筹资就低不就高”压缩了筹资上调空间；
 - “待遇就高不就低、目录就宽不就窄”释放需求→支付压力增大。

5. 发展趋势

1. **开展“三保合一”探索**：未来方向是将城乡居民医保与城镇职工医保进一步统合，实现更高层次的一体化。
2. **提高统筹层次、但要防“大锅饭”**：人口流动常态化要求更高层级统筹，但地区间筹资差异大，盲目统一可能影响效率。

3. **推进商保经办基本医保工作**：可缓解编制不足、监管压力和异地结算问题，也给制度创新留空间。
4. **探索完善筹资动态调整机制**：建立与收入增长挂钩的更稳定机制，缓解基层征缴难。

五、补充医疗保险

1. 概念

- **广义**：除国家和社会建立的基本医疗保险之外的各种医疗保险总称。
- **狭义**：对基本医疗保险的补充，只要是以基本医保为主体、其余为补充的形式，都可归入。
(英文：supplementary medical insurance)

2. 特征

1. **补充性**：是最核心特征，弥补基本医保覆盖不足。
2. **非福利性**：多投多得，少投少得，不投不得。
3. **客观性**：要与当地经济和医疗消费水平相适应。
4. **多样性**：多种模式共存。
5. **自愿性**：与基本医保的强制性形成对比。

3. 保障范围

- **按人群**：一类是企事业单位职工；一类是未纳入社会医保范围的人群。
- **按保障水平**：可对门诊自付部分、起付线以上住院费用等进行补偿。

4. 补充医疗保险的种类

1. 按基本医保服务管理分：住院补充、门诊补充、门诊特殊病补充；
2. 按是否营利分：营利性与非营利性；
3. 按保障范围分：封顶线以上费用、封顶线以下特种病、综合性；
4. 按参保范围分：公务员医疗补助、企业补充医疗保险等；
5. 按承办机构分：社保机构承办、社保+商业联合承办、企业承办、商业独立承办。

5. 与其他保险的关系

- **与基本医疗保险**：
 - **联系**：目标同为分散疾病经济风险，筹资原则相似，支付原则相似；
 - **区别**：性质、作用、权利义务、待遇水平、立法层级均不同。

- 与商业医疗保险：
 - 区别：性质不同、对象和作用不同、权利义务不同；
 - 联系：部分补充医保项目会参照商业保险模式运营或委托商业保险公司经营。

6. 发展与挑战

- 需要政府推动；
- 需要一定的“半强制”推广方式扩大覆盖；
- 需要借鉴国外经验、创新险种，使之更好衔接基本医保。

六、重点英文单词与表达（按章节汇总）

1. 总体与结构类

- 多层次医疗保障体系 multi-level medical security system
- 基本医疗保险 basic medical insurance
- 医疗救助 medical assistance
- 补充医疗保险 supplementary medical insurance
- 商业健康保险 commercial health insurance
- 医疗互助 medical mutual aid
- 慈善捐赠 charitable donation
- 以...为主体 take ... as the main body
- 以...为托底 serve as the bottom line
- 覆盖范围 coverage

2. 职工基本医疗保险类

- 城镇职工基本医疗保险 urban employee basic medical insurance
- 社会统筹 social pooling
- 个人账户 individual account
- 统账结合 combination of social pooling and individual accounts
- 起付线/起付标准 deductible / threshold
- 封顶线 maximum payment limit
- 定点医疗机构 designated medical institution
- 定点零售药店 designated retail pharmacy
- 异地就医结算 cross-regional (inter-provincial) direct settlement
- 医疗费用 medical expense / medical cost

- 基金可持续性 sustainability of the fund

3. 城乡居民基本医疗保险类

- 城镇居民基本医疗保险 urban resident basic medical insurance
- 新型农村合作医疗 new rural cooperative medical scheme (NRCMS)
- 城乡居民基本医疗保险 integrated urban-rural resident basic medical insurance
- 统筹层次 pooling level
- 动态调整机制 dynamic adjustment mechanism
- 基本药物目录 essential drug list
- 医疗服务项目目录 list of medical service items

4. 补充与商保类

- 企业补充医疗保险 employer-sponsored supplementary medical insurance
- 团体保险 group insurance
- 合同管理 agreement-based management
- 非营利性 non-profit
- 风险共济 risk-sharing

第十九章 我国医疗保障制度发展

一、学习目标（从目录与内容反推）

1. 掌握我国医疗保障制度从“医疗保障”走向“健康保障”的发展方向与背景。
2. 理解医保与医疗服务、医药服务、公共卫生之间的协同机制与实现路径。
3. 掌握多层次医疗保障体系中政府的责任与边界，理解政府从“管理”到“治理”的转型。
4. 了解健康保障制度未来的建设内容与总体展望。

二、第一节 医疗保障向健康保障转型

1. 医疗保障与健康保障的关系

- **医疗保障**更多指对“患病之后的医疗费用”给予经济补偿，核心是“看病能报”。
- ****健康保障（Health Security）****强调的是“全人群、全生命周期的健康维护”，不只报销看病，还包括预防、健康管理、康复、长期照护等，更前移、更全面。
- 转型的核心：从“以疾病诊疗为中心”转向“以健康为中心”。

2. “医疗保障”转向“健康保障”的背景

课件写了三类背景，要知道是多重驱动：

1. **政治背景**：国家层面提出“健康中国”“共同富裕”等战略，需要医保不只是兜底，还要服务整体健康战略。
2. **经济背景**：人口老龄化、慢性病高发、医疗费用增长快，如果只做事后报销，基金压力大，必须把关口前移、做预防，才能控费。
3. **社会背景**：居民健康需要从“能治病”提升到“少得病、得病能治、康复有保障、长期照护有支持”，居民对公平可及的健康服务需求上升。
→ 所以必须把医保放进更大的“健康保障体系”中去看。

3. 大健康理念指导下的目标表述

课件原话强调：以大健康理念为指导，以全民健康为目标，**以预防为主**，立足**全人群**和**全生命周期**两个着力点，在完善基本公共卫生服务的基础上，通过**健康促进、健康管理、环境健康管理**三大支柱，把健康模式从“透支健康、对抗疾病”转到“呵护健康、预防疾病”，实现：

- 生得优
- 活得长
- 过得好
- 病得少
- 走得安

这是健康保障的价值取向。

4. 健康保障建设的主要内容

课件列了四条，要一条条会写：

1. 多层次医疗保障体系建设

- 以基本医疗保险为主体
- 补充医疗保险、大病保险、商业健康保险等为补充
- 医疗救助兜底

2. 完善预防保障体系建设

- 把预防、公共卫生纳入统筹
- 强调健康教育、健康促进

3. 推进康复保障体系建设

- 疾病后期的康复、功能恢复要有制度支持

4. 建立并完善长期护理制度（Long-term Care System）

- 针对失能、半失能老年人和长期照护需要的群体
 - 是老龄化背景下健康保障的重要一环
- 这四块加起来，才叫“健康保障制度体系”。

5. 健康保障建设的难点与展望

课件说“医改纵深发展、缺乏顶层设计、政策制定衔接困难”，说明现在的问题是**碎片化**和**制度间不衔接**。展望里有几条要点：

- 健康保障制度设计要**把握国家大政方针**，做**统筹规划**。
- 要从**顶层设计**出发，先把政府该管的说清楚，再“充分发挥市场机制作用”，**积极引入商业补充保险**。
- 各种保障制度要**明确保障范围、界定权利与义务**，做到**全覆盖且交接有序**。

- 不同制度之间要从**参保范围、服务需求、服务方式、筹资方式、制度衔接、服务衔接**等方面，分析并界定彼此边界。
- 最终目标结构被课件概括为一句话：
“预防保障先行，医疗保障覆盖，康复保障补贴，医疗救助兜底，长期照护保障”
这一句是将来写作或考试能直接引用的表述。

三、第二节 医疗保险体系与其他体系的协同性

这一节是本章的“操作性”部分，讲医保怎么去带医疗、带药品、带公卫走，三个协同要分清。

（一）医疗保险与医疗服务的协同

1. 改革医保支付方式，建立分担机制，规范医疗服务

- 制定医保基金**总额预算管理、按床日付费（per diem）、按人头付费（capitation）、**按病种付费（case-based payment）****等技术规范。
- 建立**定点医院医保基金支付超额时的医院-医保分担机制**。
- 把**医院**作为超额成本和结余奖励的责任主体，鼓励医院主动控费，减少过度医疗。
- 以综合医院为主体，探索**多元复合式医保支付方式**，推进**区域医保基金总额预算点数法改革**，引导医疗机构合理诊疗。
→ 核心：用支付方式改革去控费用、调行为。

2. 建立健全医保引导机制，引导合理就医，促进基层首诊与分级诊疗

- 完善与基层服务能力相匹配的医保政策。
- **提高患者基层首诊报销比例，拉大不同级别医疗机构报销差距**。
- 未按转诊程序就医的，**降低医保支付比例**或不予支付。
- 通过起付线、报销比例、支付方式等政策工具，把常见病、慢性病、康复等患者**下沉到基层**。
- 配合**医共体建设、县镇村一体化**，形成真正的分级诊疗格局。

3. 完善医保基金监管机制，强化医疗服务精细化管理

- 推进医疗机构精细化管理，强化医院经济运行和财务管理，从**医疗服务端**建立医保基金的监管机制，实现“医疗-医保”联动。
- 健全**临床合理用药与监测评价制度**，重点对高额费用、抗菌药物、贵重药品、高值耗材做**预警监控**。
- 落实处方、医嘱、检查检验单的**动态监测、分析点评、公示通报、约谈整改制度**。
- 建立**医疗服务、药品价格和医保支付的信息共享机制**，一方面医保调控医疗行为，另一方面医疗端也能反向监督基金使用。

(二) 医疗保障与医药服务的协同

1. 完善医保药品目录动态调整机制，满足患者用药需求

- 建立并完善医保药品目录调整规则及指标体系，**动态调整优化目录**。
- 把“临床价值高、患者获益明显、经济性好”的药品及时纳入医保支付。
- 健全医保药品评价机制，监测目录落地情况，支持创新药，提高谈判药品可及性。
- 将符合条件的**中药**纳入医保，**探索符合中医药特点的医保支付方式**，发布中医优势病种，鼓励中西医“同病同效同价”。

2. 优化医药服务价格形成机制，控制居民医药费用负担

- 深化药品、医用耗材****集中带量采购（volume-based procurement, VBP）****制度改革，常态化实施，扩大到高值医用耗材。
- 推进并规范**医保基金与医药企业直接结算**，让支付标准和采购价格协同。
- 配套落实**结余留用**等激励约束机制，使集中采购成为公立医疗机构药品采购的主导模式，同时鼓励社会办医疗机构、定点零售药店参与。
- 探索一种既能体现政府作用、又能体现医疗机构技术劳务价值的**医疗服务价格形成机制**。

3. 加强药品流通医保监管机制，防止资金违规使用

- 医保局与药监部门建立**长效协作机制**，对药品生产-流通-销售**全流程监管**，防止医保基金被违规套取。
- 通过规范药品流通、提高准入门槛、加强日常监管和飞行检查、打击灰色交易、推进电子监管和全程可追溯，淘汰不合规企业。
- 扩大医保定点零售药店范围，建立**互联互通电子处方管理平台**，允许患者凭处方在医疗机构或药店自主购药。

(三) 医疗保障与公共卫生的协同

1. 统筹使用的两种基本方式

- 方式一：医保基金与公卫资金**资金池合并、统一管理支付**；
 - 方式二：建立**部门协调支付机制**，各管一块但协同使用，实现无缝衔接。
- 不管哪种方式，都要做到：
- 统筹健康领域发展规划
 - 加大公共卫生筹资力度
 - 探索一体化补偿机制
 - 明确健康导向，优化绩效考评
 - 整合信息平台，为协同统筹提供数据支撑
- 这些是考试容易出“路径题”的点。

2. 国内外经验

- 国外：
 - 荷兰：公共卫生费用与医保基金**捆绑支付**

- 德国：法定健康保险购买预防保健服务
- 美国：建立整合型保健组织，实行**打包付费（bundled payment）**
- 国内：
 - 厦门“三师共管”
 - 深圳罗湖：以健康为导向的医保**按签约人头定额付费**
 - 浙江德清县：按人头总额预付、结余留用
 - 福建“三明模式”这些例子可以作为“协同的可行实践”来记。

四、第三节 政府责任与边界

1. 医疗保障治理的基本概念

- **医疗保障治理**：以共建共治共享为理念，围绕医保治理改革和关键问题解决，通过**组织、制度、机制、结构、功能、要素**的构建，把顶层设计变成可操作的行动系统。
- 要回答三个问题：
 - i. 谁来治理（多元主体、以政府为主导）
 - ii. 治理什么目标和功效（公平、可持续、高质量）
 - iii. 用什么手段治理（制度、支付、监管、信息化等）
- 特别强调“**动静融合**”：不是写制度就完了，要能落地。

2. 我国医疗保障治理与政府转型历程

- 计划经济时期是“**全能型政府**”，特点是“大政府、小社会”，主要靠行政命令、文件调控。
- 随着市场经济改革推进，行政干预可以“快纠偏”，但难以解决顶层设计和深层次问题。
- 进入新发展阶段后，政府管理要向****政府治理（governance）****转变，更多运用规则、协同、社会参与。
- 当前问题：多层次医疗保障体系还不完善，基本医保、补充医保、医疗救助、商业保险之间**水平差、衔接差、可持续性有待提高**，所以需要政府把责任和边界说清楚。

3. 政府在基本医疗保险与补充医疗保险中的责任

1. 为什么政府要承担主体责任？
 - 基本医保和补充医保是国家给全体社会成员在患病时提供的**基本医疗援助**，带有很强的**社会互助和收入再分配**功能。
 - 具有明显的**公共产品属性**：人人可享受，互不排斥，市场主体难以做到覆盖全体且长期稳定。

- 因此只有政府能为全体社会成员提供**持续、稳定、覆盖面广**的基本医保和补充医保待遇，所以政府必须当“主心骨”。

2. 政府的主要责任（可按常见表述归纳）

- 制定制度和顶层设计：确定覆盖人群、待遇范围、筹资方式
- 承担适度财政投入，保障基本制度可持续
- 监管基金安全，防止骗保、滥用
- 组织实施与经办管理，确保人人享有基本医疗保障

（课件标题出现“2. 我国基本医疗保险与补充医疗保险制度政府责任”，可按上面四点展开写）

4. 政府在医疗救助中的责任

1. 医疗救助的性质

- 属于**社会救助体系中的专项救助**
- 面向**因病无经济能力治疗的贫困人群**
- 提供**资金、政策与技术支持**，帮助其治疗，防止因病致贫返贫

2. 为什么要政府兜底？

- 从个体看：保障生命健康、恢复发展能力
- 从社会看：涉及社会文明、公平正义、社会稳定
- 所以这一块必须政府做“最后一道网”。

- ## 3. 政府责任可写成：
- 建立医疗救助制度、明确救助对象、筹资和财政保障、与医保等制度衔接、监督救助资金使用等。

5. 非制度化医疗保障中的政府责任

1. 非制度化医疗保障的含义

- 指商业保险、慈善救助、医疗互助等制度外的保障形式
- 主要解决“基本医保体系之外”的那部分：未保病种、未保药物、未保费用、未保服务
- 在重大疾病风险分担中有补充作用

2. 政府要做什么？

- **引导与培育责任**：释放市场潜能，鼓励商业健康保险等发展，形成与基本医保互补的格局
- **监管责任**：建立规范的市场环境，防范侵害参保人权益的行为，在公平与效率之间取得平衡
- 简单说：这块不是政府全包，但政府要“扶上马、管规范”。

五、重点英文单词（按本章内容整理）

1. 医疗保障：**Medical Security**

2. 健康保障：**Health Security / Health Protection**

3. 基本医疗保险: **Basic Medical Insurance**
4. 补充医疗保险: **Supplementary Medical Insurance**
5. 大病保险: **Catastrophic Medical Insurance**
6. 长期护理保险 / 制度: **Long-term Care Insurance / System**
7. 多层次医疗保障体系: **Multi-level Medical Security System**
8. 医疗服务体系: **Medical Service System**
9. 医疗保障与医疗服务协同: **Coordination between Medical Security and Medical Services**
10. 总额预算: **Global Budgeting**
11. 按床日付费: **Per Diem Payment**
12. 按人头付费: **Capitation**
13. 按病种付费: **Case-based Payment** (可联系 DRG 思路记)
14. 定点医疗机构/定点医院: **Designated Medical Institution / Designated Hospital**
15. 分级诊疗: **Tiered/Hierarchical Medical Care**
16. 医疗共同体: **Medical Consortium / Medical Community**
17. 集中带量采购: **Volume-based Procurement (VBP)**
18. 医疗服务价格形成机制: **Price Formation Mechanism for Medical Services**
19. 公共卫生: **Public Health**
20. 打包付费: **Bundled Payment**
21. 医疗救助: **Medical Assistance**
22. 商业健康保险: **Commercial Health Insurance**
23. 医保基金监管: **Supervision of Medical Insurance Fund**
24. 顶层设计: **Top-level Design**
25. 信息共享机制: **Information-sharing Mechanism**